

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PRÉ-NATAL



JOINVILLE
2025



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

GERÊNCIAS DE DISTRITOS SANITÁRIOS

Ana Aparecida Pereira - Distrito Norte

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann - Distrito Centro

Elisarb Mirapalhete Rodrigues Vilar - Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL

Ana Caroline Giacomini

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski

ELABORAÇÃO - 2017

Rosimeire Pereira Bressan

REVISÃO - 2020

Giovana da Rosa Goulart

Cristiane Soares

Flavia Favaretto

Janaina Pravato Vicente Banin

Renata Andrade Teixeira Heill

Maria Simone Pan

REVISÃO - 2025

Fabiane Cherobim (*in memoriam*)

Fernanda Spiller

Giorgio Tondello

Janaina Pravato Vicente Banin

Jhoselin Alves

Sarah Jacinto



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ATUALIZAR

ACS - Agente Comunitário de Saúde	IMC - Índice de Massa Corporal
AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>)	IST - Infecções Sexualmente Transmissíveis
APS - Atenção Primária à Saúde	ITU - Infecção do Trato Urinário
BCF - Batimentos Cardíacos Fetais	MDV - Maternidade Darcy Vargas
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	mg - Miligrama
CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador	mg/dL - Miligrama por Decilitro
CID - Classificação Internacional de Doenças	mmHg - Milímetro de Mercúrio
DM - Diabetes Mellitus	MS - Ministério da Saúde
DMG - Diabetes Mellitus Gestacional	Nº - Número
DPP - Data Provável do Parto	PA - Pressão Arterial
dT - Difteria e Tétano	PA 24 horas - Pronto Atendimento 24 horas
dTpa - Tríplice Bacteriana Acelular do Adulto (Difteria / Tétano / Coqueluche)	PNAR - Pré-Natal de Alto Risco
DUM - Data da Última Menstruação	POP - Procedimento Operacional Padrão
E-mail - Endereço Eletrônico	RN - Recém-nascido
ESF - Estratégia Saúde da Família	SAE - Serviço de Assistência Especializada
FATOR Rh - Antígenos Eritrocitários (Rhesus)	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Fe - Ferro	SIG-SAUDETECH - Sistema Integrado de Gestão
g - Grama	SUS - Sistema Único de Saúde
g/dL - Grama por Decilitro	TN - Translucência Nucal
GO - Ginecologista Obstetra	TR - Teste Rápido
°C - Grau Celsius	TRG - Teste Rápido da Gravidez
Hb - Hemoglobina	TTGO - Teste de Tolerância a Glicemia Oral
HBsAg - Antígeno de Hepatite B	UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família
HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	UI - Unidade Internacional
HJAF - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria	UPA 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento 24 horas
HRHDS - Hospital Regional Hans Dieter Schmidt	USG - Ultrassonografia
IG - Idade Gestacional	VDRL - Teste de Laboratório de Pesquisa em Doenças Venéreas
IgG - Imunoglobulina G	VO - Via Oral
IgM - Imunoglobulina M	
IM - Intramuscular	



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	6
1. AVALIAÇÃO PRÉ-CONCEPCIONAL.....	7
2. CONDUÇÃO DA GESTANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS).....	10
2.1. Captação precoce da gestante.....	10
2.2. Condutas administrativas imediatas após identificação da gravidez.....	10
2.3. Periodicidade das Consultas no Pré-Natal.....	11
2.4. Acompanhamento Geral da Gestante.....	12
2.4.1. Calendário de Imunização da Gestante.....	12
2.4.2. Orientações para o acompanhamento da gestante conforme período gestacional...	12
2.5. Exames realizados durante o Pré-Natal.....	13
2.5.1. Exames de Rotina por Trimestre.....	13
2.5.2. Ultrassonografia.....	21
2.6. Plano de Parto.....	22
Os profissionais da APS devem orientar e estimular a gestante a construir seu plano de parto (Processo SEI nº 22.0.356882-2).....	23
3. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL.....	24
3.1. Gestante de Baixo Risco (Risco Habitual) - Até 4 Pontos.....	26
3.2. Gestante de Médio Risco (Risco Intermediário) - 5 a 9 Pontos.....	26
3.3. Gestante de Alto Risco - 10 ou Mais Pontos.....	26
4. TELECONSULTORIAS.....	26
4.1. Teleconsultoria no Pré-Natal.....	27
4.2. Teleconsultoria em Especialidades.....	27
5. MANEJO DE SITUAÇÕES ESPECIAIS NA GESTAÇÃO.....	28
5.1. Doença Hipertensiva na Gravidez.....	28
5.1.1. Profilaxia de Doença Hipertensiva na Gravidez.....	30
5.1.1.1. Profilaxia com Carbonato de Cálcio.....	30
5.1.1.2. Profilaxia Com Ácido Acetilsalicílico (AAS).....	30
5.1.2. Manejo das Síndromes Hipertensivas.....	31
5.1.2.1. Gestante com Menos de 20 Semanas:.....	31
5.1.2.2. Gestante com Idade Gestacional Maior ou Igual a 20 Semanas.....	31
5.1.3. Acompanhamento Pós-Parto da Gestante com Doença Hipertensiva na Gravidez..	32
5.1.3.1. Puérpera com Hipertensão Crônica sem Pré-Eclâmpsia Sobreposta na Gestação ou com Síndromes Hipertensivas Na Gestação que não Necessitou Uso de Medicação.....	32
5.1.3.2. Puérpera com Diagnóstico de Pré-Eclâmpsia na Gestação.....	32
5.2. Diabetes Mellitus na Gravidez.....	33
5.2.1. Acompanhamento Pós-Parto da Gestante com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) ou Diabetes Mellitus (DM).....	34
5.2.2. Puérpera com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG).....	35
5.2.3. Puérpera com DM Prévia (DM1 e DM2).....	35
5.3. Infecção do Trato Urinário (ITU) na Gestação.....	35
5.3.1. Recidiva ou Reinfecção de ITU.....	37
5.3.2. Queixas Urinárias Comuns da Gestação sem Necessidade de Intervenção.....	37
5.4. Sífilis na Gestação.....	37
5.4.1. Tratamento da Sífilis na Gestação.....	38
5.4.2. Dessensibilização à Benzilpenicilina Benzatina em Gestante com Sífilis.....	38



5.5. Cuidado Periodontal na Gestação.....	39
5.6. Tromboembolismo.....	39
5.6.1. Prevenção do tromboembolismo.....	39
5.6.2. Prevenção e Tratamento Medicamentoso para tromboembolismo.....	40
5.7. Gestantes com Agravos à Saúde Possivelmente Relacionadas ao Trabalho.....	40
6. CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL DA GESTANTE E PUÉRPERA EM SAÚDE MENTAL.....	41
6.1. Riscos Psicossociais em Gestante e Puérpera.....	41
6.2. Encaminhamentos das Gestantes e Puérperas para Serviços de Saúde Mental.....	42
6.2.1. Situações para Avaliação e Manejo na Atenção Primária (APS).....	42
6.2.2. Situações para Avaliação e Manejo em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)..	42
6.2.3. Situações para Avaliação e Manejo em Emergências Hospitalares e Pronto Atendimento.....	43
6.2.4. Situações que Necessitam de Internação em Leitos de Saúde Mental.....	43
7. VIOLÊNCIA.....	43
7.1. Violência Sexual.....	43
7.2. Outras Violências.....	44
8. SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS QUE INDICAM AVALIAÇÃO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA.....	44
9. PARTO.....	45
9.1. O Parto e a Violência Obstétrica.....	46
9.2. Doação Voluntária e Família Acolhedora.....	46
10. CONSULTA DE PUERPÉRIO E DO RECÉM NASCIDO.....	47
10.1. COMPLICAÇÕES PUERPÉRAIS QUE NECESSITAM SER NOTIFICADAS PARA A MATERNIDADE.....	49
10.1.1. Endometrite.....	49
10.1.2. Infecção de Sítio Cirúrgico - ISC.....	49
10.1.3. Infecção de Episiotomia.....	50
11. PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO.....	50
12. INDICADORES.....	51
12.1. Indicadores Gerais Rede Alyne.....	51
12.2. Indicadores Específicos da Rede Alyne.....	51
12.2.1. Indicador C3 - Cuidado na Gestação e Puerpério.....	51
13. ALTERAÇÕES DO PROTOCOLO DE PRÉ-NATAL (VERSÃO 2020 PARA 2025).....	52
REFERÊNCIAS.....	54

INTRODUÇÃO

Este protocolo é um instrumento de ordenação com a função de orientar e padronizar a assistência ao Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde de Joinville, visando à realização de uma prática humanizada, racional e custo-efetiva que viabilize a atenção integral à gestante e à família e em conformidade com a Rede Alyne (Portaria GM/MS Nº 5.350, de 12/09/2024), que é a rede voltada à atenção à saúde materna e infantil do Sistema Único de Saúde (SUS), que atualizou e aprimorou a antiga Rede Cegonha.

O cuidado pré-natal na Atenção Primária à Saúde (APS) deve assegurar o acolhimento, o início precoce do acompanhamento, e o bem-estar da mãe, do pai e da criança, sendo fundamental estabelecer o vínculo com o serviço de saúde. O atendimento deve ser equânime e livre de qualquer discriminação (raça, etnia, identidade/expressão de gênero, orientação sexual, cultural, classe), visando o desenvolvimento saudável da gestação, parto e nascimento do recém-nascido.

Nesse contexto, o protocolo foi estruturado baseado nas etapas desde a avaliação pré-concepcional até a **CONSULTA DE PUERPÉRIO E DO RECÉM NASCIDO e Amamentação**

Nesta versão, foram consideradas informações atualizadas do Ministério da Saúde e documentos norteadores do Estado, realizadas articulações com profissionais da Maternidade Darcy Vargas e de diversas áreas da Secretaria Municipal da Saúde, bem como a colaboração através da submissão à consulta técnica.

O documento orienta quanto à competência dos níveis de atenção, observando o grau de complexidade e resolutividade de cada um deles, levando em conta a estratificação de risco e o encaminhamento assistencial mais adequado.

É um guia simplificado e, para maiores detalhamentos, consultar as referências citadas no decorrer do documento e ao final dele.



1. AVALIAÇÃO PRÉ-CONCEPCIONAL

A avaliação pré-concepcional é um atendimento de saúde oferecido à mulher, ao homem ou ao casal em idade reprodutiva, antes da concepção, com o objetivo de identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação e constitui um instrumento importante na melhoria dos índices de morbidade e mortalidade materna e infantil.

As atividades a serem desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem incluir anamnese, exame físico, exame ginecológico completo, além de exames laboratoriais.

Nos Quadros 01, 02 e 03 estão descritas orientações específicas relacionadas aos cuidados pré-concepcionais, que deverão ser utilizadas na APS para o atendimento.

Quadro 01. Avaliação pré-concepcional específicas quanto aos hábitos e o estilo de vida

HÁBITO E ESTILO DE VIDA	ORIENTAÇÕES PARA APS
Orientação nutricional	Equilibrar o estado nutricional, corrigir deficiências e otimizar a fertilidade.
Orientações sobre os riscos do tabagismo, uso rotineiro de bebidas alcoólicas e outras drogas.	Analisar a necessidade de encaminhamento e cuidado compartilhado com outros serviços e rotinas como: Grupo de Tabagismo, CAPS AD ou outros.
Orientações quanto ao uso de medicamentos	Avaliar a manutenção ou substituição para medicamentos com menores efeitos sobre o feto.
Avaliação das condições de trabalho	Orientar sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos ambientais ou outros.
Medidas educativas	Orientar para a realização de atividade física, registro sistemático das datas das menstruações e o estímulo ao aumento do intervalo interpartal (Ministério da Saúde recomenda um intervalo mínimo de dois anos entre gestações), etc.

Elaborado por: NGQ, 2025



Quadro 02. Avaliação pré-concepcional quanto à investigação de saúde

INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE	ORIENTAÇÕES
Rubéola e Hepatite	Providenciar a imunização prévia à gestação, nos casos negativos.
Toxoplasmose	Orientar sobre cuidados gerais para evitar a contaminação e, no diagnóstico de contaminação recente de toxoplasmose, deve-se esperar pelo menos 6 meses após a cura para engravidar.
HIV/Aids	Incentivar a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste.
Sífilis	Tratar a mulher, nos casos positivos, e seu(s) parceiro(s) para evitar a evolução da doença e a sífilis congênita e orientar sobre os cuidados.
Outras ISTs	Incentivar a testagem para diagnóstico e, nos casos positivos, instituir tratamento no momento da consulta (abordagem sindrômica - permite o início do tratamento antes do resultado dos exames) e orientar para sua prevenção.
Hemograma completo com avaliação da tipagem sanguínea e fator Rh.	Avaliar resultados e iniciar condutas com relação a Anemia e Doença Hemolítica Perinatal (Quadro 09 deste protocolo)
Glicemia de Jejum	Realizar o exame para diagnóstico e manejo de diabetes mellitus prévia à gestação.
Câncer de Colo Uterino	Citopatológico colo uterino.

Elaborado por: NGQ, 2025

Quadro 03. Avaliação pré-concepcional nas doenças crônicas

DOENÇAS CRÔNICAS	ORIENTAÇÕES
Diabetes mellitus e hipertensão arterial crônica	Informar que o controle prévio à gestação, e durante esta, reduz significativamente o risco de macrosomia, malformação fetal, de abortamentos e/ou mortes perinatais.
Epilepsia	Orientar sobre a prescrição universal do ácido fólico prévio à concepção (Quadro 05).
Hipotireoidismo / Hipertireoidismo	Ajustar TSH dentro da faixa pré-concepção
Infecção pelo HIV	Orientar que o controle pré-concepcional no casal portador do HIV, acrescidos das técnicas de assistência preconizadas para a concepção em casais HIV+ (sorodiscordantes ou soroconcordantes) e das ações para a prevenção da transmissão vertical durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, incluindo a não amamentação, permite que a gestação ocorra em circunstâncias de risco reduzido para a mulher e para a criança, promovendo melhores resultados maternos e perinatais.
Anemias	Avaliar e iniciar o uso de Sulfato Ferroso (Quadro 09).
Carcinomas de colo uterino e de mama	Realizar exames de rotina para rastreio destes cânceres e outros que indicarem necessidade..
Doenças Psiquiátricas (Depressão, Transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade grave, etc)	Acompanhar saúde mental e suporte psicossocial e reavaliar fármacos.

Elaborado por: NGQ, 2025



No Quadro 04 estão descritas ações relacionadas aos cuidados pré-concepcionais da parceria, que deverão ser utilizadas no atendimento.

Quadro 04. Ações recomendadas aos cuidados pré-concepcionais da parceria

CATEGORIA	AÇÃO RECOMENDADA	JUSTIFICATIVA E IMPACTO
Rastreamento de ISTs	Realizar testes para Sífilis, HIV, Hepatites B e C e, se indicado, outras ISTs (Clamídia, Gonorreia).	Prevenção da transmissão à parceira e, subsequentemente, da transmissão vertical (ex: Sífilis Congênita). Permite tratamento antes da gravidez.
Imunização	Atualizar o Cartão de Vacinação, com foco em: Tríplice Viral (Rubéola), Hepatite B e dT.	Prevenção da transmissão de doenças potencialmente teratogênicas, como a rubéola, para a gestante e o feto.
Hábitos Nocivos	Orientar a cessação total do uso de Tabaco e Drogas Ilícitas e a redução ou eliminação do Alcool.	Melhora a qualidade seminal (aumentando a chance de concepção) e elimina a exposição passiva da parceira a toxinas.
Saúde e Peso	Realizar consulta médica (clínica ou de urologia) para controle de doenças crônicas (ex: Diabetes, Hipertensão) e avaliação do IMC.	Otimização da saúde geral e sexual. O peso e as doenças crônicas podem afetar a fertilidade e a espermatogênese.
Medicamentos e Toxinas	Revisar o uso de medicamentos e suplementos com o profissional de saúde e minimizar a exposição ocupacional a agentes tóxicos.	Alguns medicamentos ou toxinas ambientais podem ser prejudiciais à produção de esperma e à fertilidade do casal.

Elaborado por: NGQ, 2025

No Quadro 05 estão descritos os medicamentos a serem prescritos no período pré-concepção, com o objetivo de prevenção de situações específicas.

Quadro 05. Prescrição de medicamentos na pré-concepção

MEDICAMENTO	ORIENTAÇÃO
Ácido Fólico	Prescrever de maneira universal no período pré-gestacional, para a prevenção de defeitos congênitos do tubo neural . • Suplementar idealmente 3 meses antes da concepção com Ácido Fólico 5mg/dia até a 12ª semana completa (12 semanas e 6 dias) de gestação.
Sulfato Ferroso	Avaliar e instituir no período pré-gestacional, quando diagnosticadas anemias ou deficiência de ferro , com o objetivo de restaurar as reservas de ferro do corpo antes da gravidez. • Se necessário, suplementar conforme resultado do hemograma (<u>Quadro 09</u>).
Importante: A Nota Técnica Conjunta nº 05/2025 orienta sobre a “Prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso, Carbonato de Cálcio e Vitamina A + Vitamina D pelo Médico, Enfermeiro, Nutricionista e/ou Farmacêutico na assistência à Pré-concepção, Pré-natal e Puericultura” (Processo SEI nº 25.0.207373-6)	

Elaborado por: NGQ, 2025



2. CONDUÇÃO DA GESTANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

2.1. Captação precoce da gestante

As UBSFs devem ser a porta de entrada da gestante para realização do pré-natal, que deve começar idealmente antes da 12ª semana de gestação.

Uma forma de captação precoce é a realização de **Teste Rápido de Gravidez**, em qualquer ponto de atenção da rede, seguindo o **POP nº 51 - Como Realizar Teste Rápido para Detecção de Gravidez** (SEI nº 20.0.183593-5).

Quando algum serviço fora da APS identificar um TR com resultado reagente, deverão imediatamente realizar a contrarreferência para a APS para que o cuidado no Pré-natal seja iniciado imediatamente, conforme **POP nº 19 - Transferência do Cuidado via Notificação de Contrarreferência** (Processo SEI nº 20.0.144936-9).

Importante: Se TRG der negativo e persistir amenorreia após 15 dias, orientar a usuária a voltar à UBSF e realizar novo TRG.

Se persistir o resultado não reagente e a história clínica com possibilidade de gestação, médico ou enfermeiro devem solicitar o exame de Hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (βHCG).

Persistindo amenorreia com resultado não reagente e ausência de batimento cardíaco fetal (BCF), a mulher deve retornar ao médico para avaliação clínica.

Quando ocorrer **atraso da aplicação dos anticoncepcionais injetáveis**, o tempo de atraso para realização do teste deve seguir a indicação da bula do insumo disponível, com atenção aos Fluxogramas sugestivos de manejo no atraso da aplicação dos anticoncepcionais injetáveis (Processo SEI nº 23.0.293817-2).

2.2. Condutas administrativas imediatas após identificação da gravidez

É importante que no momento da identificação da gravidez, imediatamente sejam tomadas todas as condutas **administrativas** necessárias, tais como as citadas no Quadro 06, além de outras.

Quadro 06. Condutas administrativas imediatas após identificação da gravidez

CONDUTAS ADMINISTRATIVAS
Atualizar o cadastro da gestante no SIG-SaudeTech (qualquer profissional da equipe).
Verificar se o cadastro da gestante no SIG-SaudeTech está vinculado à Equipe de Saúde de referência (em caso negativo, informar o ACS de referência).



CONDUTAS ADMINISTRATIVAS

Realizar o cadastro no sistema SIG-SaudeTech preenchendo o item **Condicionabilidade: Gestante**, e se atentar para o preenchimento completo de todas as informações solicitadas para o cadastro.

Incluir em **planilha de controle de gestante** disponível na unidade.

Abrir e registrar todos os atendimentos e condutas no **Cartão da Gestante**, conforme informação disponibilizada no Processo SEI nº 23.0.172670-8.

Entregar a **Cartilha Mãe Joinvilense** para que a gestante e/ou rede de apoio tenham acesso às informações deste período (disponível para impressão no Processo SEI nº 22.0.257776-3).

Avaliar a **vacinação** da gestante e encaminhar para realizar as vacinas faltantes, conforme [link: Calendário Técnico Nacional de Vacinação da Gestante](#).

Identificar o parceiro(a), pois o mesmo(a) também tem o direito de ser cuidado (realização de consultas e exames) e ter acesso a informações, como as descritas no "**pré-natal do parceiro**" conforme [link: Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde](#), respeitando a LGPD. **Atenção: Registrar o Procedimento "Consulta Pré-Natal do Parceiro"**

Realizar **busca ativa** em caso de falta nas consultas, sempre registrando a busca no prontuário.

Elaborado por: NGQ, 2025

2.3. Periodicidade das Consultas no Pré-Natal

Confirmada a gravidez, a primeira consulta deve ser realizada o mais precocemente possível, preferencialmente até 12 semanas de gestação, garantindo no mínimo 7 (sete) consultas durante a gravidez, intercalando consultas médicas e de enfermagem e 1 (uma) no puerpério conforme periodicidade descrita no Quadro 07.

Quadro 07. Distribuição dos atendimentos durante a gestação e puerpério

CUIDADO	RECOMENDADO	PROFISSIONAL
Pré-natal	Atendimentos mensais até a 28ª semana	Consultas intercaladas entre Médico e Enfermeiro da ESF
	Atendimentos quinzenais da 28ª até a 36ª semana	
	Atendimentos semanais da 36ª semana até o parto ou 40ª semana	
	Ao menos 03 (três) visitas domiciliares, sendo a primeira em até 30 dias após a primeira consulta	Agente Comunitário de Saúde (ACS)
	Ao menos 01 (uma) avaliação odontológica	Cirurgião Dentista
Puerpério	Primeira consulta: preferencialmente atendimento em conjunto com a puérpera e recém-nascido entre o 3º até o 5º dia pós-parto.	Médico e/ou Enfermeiro
	Segunda consulta entre o 30º e 40º dia pós-parto	Médico e/ou Enfermeiro
	Ao menos 01 (uma) visita domiciliar feita por ACS	Agente Comunitário de Saúde

Elaborado por: NGQ, 2025



2.4. Acompanhamento Geral da Gestante

2.4.1. Calendário de Imunização da Gestante

Tomar as vacinas recomendadas durante a gravidez ajuda a proteger a gestante e o bebê de doenças potencialmente graves.

O [Calendário Técnico Nacional de Vacinação da Gestante](https://www.gov.br/saude/pt-b) deve ser seguido conforme preconiza o Ministério da Saúde (disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-b>).

2.4.2. Orientações para o acompanhamento da gestante conforme período gestacional

As orientações gerais para o acompanhamento da gestante, segmentadas conforme o seu período gestacional, estão apresentadas e detalhadas no [Quadro 08](#).

Quadro 08. Orientações gerais para acompanhamento da gestante conforme período gestacional

ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE CONFORME PERÍODO GESTACIONAL	1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)
Gestantes com mais de 12 semanas, iniciar a profilaxia com Carbonato de Cálcio* de forma universal. (<i>Item 5.1.1.1 deste protocolo</i>).	x	x	x
Avaliar a necessidade de prescrever Ácido Acetilsalicílico , conforme fatores de risco. (<i>Item 5.1.1.2 deste protocolo</i>).	x	x	
Avaliar a prescrição de Sulfato Ferroso* , a partir do conhecimento da gravidez até 3º mês do pós-parto. (<i>Quadro 05 deste protocolo</i>).	x	x	x
Avaliar a prescrição de Ácido Fólico* (<i>Quadro 05 deste protocolo</i>).	x		
Verificar o IMC.	x	x	x
Realizar ao menos 7 registros de cada rotina abaixo durante o pré-natal, que contarão como indicador de desempenho: Pressão Arterial, Peso e Altura	x	x	x
Avaliar risco gestacional a cada consulta, conforme Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional. (<i>Item 3 deste protocolo</i>)	x	x	x
Vacina dTpa com 20 semanas: Deverá ser realizada, a cada gestação, a partir da 20ª semana de gestação, e conta como indicador de desempenho (<i>Item 2.4.1 deste protocolo</i>).		x	
Verificar Batimentos Cardíacos Fetais (BCF) e Altura Uterina (AU) conforme técnica descrita no Cadernos de Atenção Básica, n° 32 - Atenção ao pré-natal de baixo risco .		x	x
Orientar e auxiliar na elaboração do plano de parto e revisar sempre que necessário. (<i>Item 2.4.2 desta linha</i>)			x
Orientar a procurar a UBSF para a primeira consulta do RN e Puérpera na Atenção Básica preferencialmente até o 5º dia de vida, junto à realização do Teste do Pezinho (Processos SEI de nº 21.0.211798-1 e 20.0.059657-0).			x
Agendar ou orientar agendamento para visita na Maternidade (MDV) via contato telefônico no número 3481-0130.			x
Orientar e incentivar o parto normal e o aleitamento materno .			x

ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE CONFORME PERÍODO GESTACIONAL	1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)
Informar sobre a preparação do parto e orientar sobre os sinais para o reconhecimento do trabalho de parto ativo, observando a idade gestacional. Atenção: O trabalho de parto é definido pela presença de duas a três contrações uterinas a cada dez minutos, com ritmo e frequência regulares. Podem ser acompanhadas de modificações cervicais caracterizadas pela dilatação maior ou igual a 2cm e/ou esvaecimento maior do que 50%.			x
Orientação para movimentação fetal: Uso do Mobilograma que propõe o registro do período de tempo, em minutos, necessário para a gestante perceber dez movimentos fetais. Esse é o chamado método da “contagem até 10”. Um movimento fetal é definido como qualquer chute ou movimento discreto, e movimentos contínuos são considerados um único movimento. O tempo total decorrido do início ao final, para atingir a contagem de dez movimentos, deve ser inferior a uma hora. Caso a gestante não detecte dez movimentos em período de uma hora, pode ser repetida a contagem por mais uma hora, e, se persistir a anormalidade, é orientado que a gestante procure um serviço de saúde. Indicações para uso do mobilograma: • Quando são relatadas diminuição, mudanças abruptas ou parada da movimentação fetal; • Gestações de alto risco; • Pós datismos (gestações acima de 40 semanas).		x	x
Importante: A Nota Técnica Conjunta nº 05/2025 orienta sobre a “Prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso, Carbonato de Cálcio e Vitamina A + Vitamina D pelo Médico, Enfermeiro, Nutricionista e/ou Farmacêutico na assistência à Pré-concepção, Pré-natal e Puericultura”, disponível no Processo SEI nº 25.0.207373-6.			

Elaborado por: NGQ, 2025

2.5. Exames realizados durante o Pré-Natal

A solicitação dos exames de rotina poderá ser feita por profissionais médicos e/ou enfermeiros.

Importante: Quando houver a necessidade de exames diferentes dos exames de rotina, estes deverão ser requisitados via SIG-SaúdeTech em: **requisição de procedimentos → cesta de exames → gestante adicionais, inserindo a justificativa "Risco Gestacional Intermediário" ou "Alto Risco", conforme resultado do Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional.**

2.5.1. Exames de Rotina por Trimestre

Os exames de rotina de acordo com a idade gestacional estão descritos no Quadro 09. Após a solicitação, deverá ser agendada nova consulta para avaliação desses exames.

Importante: Os exames laboratoriais para todas as gestantes atendidas nas Unidades de Saúde devem ser **agendados e realizados no Laboratório Municipal**, mediante a utilização dos **procedimentos que iniciam com a palavra GESTANTE** no sistema SIG SaudeTech. Todos os atendimentos realizados, prescrições de medicamentos, exames solicitados e resultados recebidos deverão ser registrados em **prontuário** e no **Cartão da Gestante** (Processo SEI nº 23.01726708).

Quadro 09. Exames de rotina de pré-natal e condutas frente aos resultados de exames conforme período gestacional

EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL E CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DE EXAMES CONFORME PERÍODO GESTACIONAL					
1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)	EXAMES DE ROTINA	RESULTADO	CONDUTAS
X			Tipagem Sanguínea e Fator Rh	Rh negativo	• Solicitar teste de Coombs indireto
X	X	X	Coombs Indireto <u>Atenção: Realizar somente em caso de resultado de Rh negativo</u>	Se Coombs indireto negativo	• Repetir mensalmente a partir da 24ª semana.
				Se Coombs indireto positivo	• Manter cuidado compartilhado com Ginecologista de referência e/ou utilizar a Teleconsultoria em Pré-natal (<u>Item 4 deste protocolo</u>); • Avaliar o Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional (<u>Item 3 deste protocolo</u>) e, se apresentar outros fatores de risco, referenciar, se necessário, ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS;
X	X	X	Hemograma completo	Hemoglobina > 11g/dL = Ausência de anemia	• Suplementar com ferro: 1 drágea de sulfato ferroso/dia (200mg), que corresponde a 40mg de ferro elementar;
				Hemoglobina entre 8 e 11g/dL = Anemia leve a moderada	• Solicitar exame parasitológico de fezes, tratar as parasitoses, se presentes, e agendar consulta médica; • Tratar anemia com 120 a 240mg de ferro elementar ao dia (normalmente, se recomenda 5 (cinco) drágeas/dia de sulfato ferroso de 40mg, via oral (podem ser 2 pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite), uma hora antes das refeições); • Repetir a dosagem de hemoglobina entre 30 e 60 dias para controle de cura: - Se os níveis estiverem subindo manter tratamento até a hemoglobina atingir 11g/dl, quando deve ser iniciada a dose de suplementação (1 drágea ao dia, com 40mg de ferro elementar); - Se a hemoglobina permanecer em níveis estacionários ou se diminuir, referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS.
				Hemoglobina < 8g/dL = Anemia grave	• Referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS.
				Importante: Na necessidade de administração de Ferro injetável , seguir as orientações detalhadas nos seguintes documentos: • Nota Orientativa conjunta nº 11/2025 - Aplicação de medicamentos imunobiológicos, citotóxicos e/ou de uso restrito a unidades de saúde via Cisnordeste no Município de Joinville (Processo SEI nº 23.0.273074-1) • Nota Orientativa Conjunta nº 14/2025 - Administração de Sais de ferro injetável (Processo SEI nº 23.0.273074-1) • POP nº 03 - Como Realizar Atendimento na Recepção em Casos de Usuários que Necessitam Aplicar Medicação Externa na Rede de Urgência e Emergência (Processo SEI nº 24.0.132074-6).	
X	X	X	Glicemia de jejum	Glicemia de jejum <92mg/dL = normal	• Realizar TTGO 75g (jejum, 1ªh e 2ªh) com IG entre 24 à 28 semanas.
				Glicemia de jejum 92 a 125mg/dl = Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)	• Orientar medidas de prevenção primária, podendo manter cuidado compartilhado com Ginecologista de referência; • Se necessário, realizar a Teleconsultoria em Pré-natal (<u>Item 4 deste protocolo</u>) e/ou • Se necessário, realizar a teleconsultoria compulsória (<u>Item 4 deste protocolo</u>) em endocrinologia para avaliação do quadro e planejamento terapêutico, conforme Protocolo de Acesso de Endocrinologia do estado de SC - 2024.
				Glicemia de jejum ≥126mg/dl = Diabetes Mellitus (DM) pré-gestacional	
				Atenção: Conforme Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional (<u>Item 3</u> deste protocolo), apenas Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) com necessidade de insulino terapia poderá ser encaminhada ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, <u>informando os valores do controle de HGT de 2 semanas.</u>	

EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL E CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DE EXAMES CONFORME PERÍODO GESTACIONAL

1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)	EXAMES DE ROTINA	RESULTADO	CONDUTAS
	X		Teste oral de tolerância à glicose com 75g (3 pontos: jejum, 1ª h e 2ª h) Atenção: <u>Não realizar em gestantes com diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus</u>	Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) Ao menos um valor de: • Jejum: 92 a 125mg/dL • 1ª hora: $\geq$ 180mg/dL • 2ª hora: 153 a 199mg/dL Diabetes Mellitus com diagnóstico na gravidez Ao menos um valor de: • Jejum: $\geq$ 126mg/dL • 2ª hora $\geq$ 200mg/dL	• Orientar medidas de prevenção primária e referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, para tele/encaminhamento, mantendo cuidado compartilhado na APS. • Orientar medidas de prevenção primária, podendo manter cuidado compartilhado com Ginecologista de referência; • Se necessário, realizar a Teleconsultoria em Pré-natal (<u>Item 4 deste protocolo</u>); e/ou • Se necessário, realizar a teleconsultoria compulsória (<u>Item 4 deste protocolo</u>) em endocrinologia para avaliação do quadro e planejamento terapêutico, conforme Protocolo de Acesso de Endocrinologia do estado de SC - 2024.
				Importante: Conforme Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional (<u>Item 3</u> deste protocolo), apenas Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) com necessidade de insulino terapia poderá ser encaminhada ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, <u>informando os valores do controle de HGT de 2 semanas.</u>	
X			TSH Atenção: <u>Solicitar apenas para gestantes com fatores de risco:</u> • Gestante >30 anos; • Hipotireoidismo e hipertireoidismo; • IMC $\geq$ 40 kg/m²; • Radiação de cabeça ou pescoço; • Doença/cirurgia de tireoide/anti-TPO reagente; • Diabetes tipo 1 ou outras doenças autoimunes; • Abortamento/perda fetal; • Parto prematuro; • Infertilidade; • $\geq$ 2 gestações anteriores; • Uso de amiodarona ou lítio; • Administração recente de contraste radiológico iodado; • História familiar de doença autoimune da tireoide ou disfunção da tireoide; • Gestante vivendo em área com insuficiência de iodo moderada a grave conhecida.	Valores de Referência normais Hipotireoidismo Hipertireoidismo	• Manter acompanhamento de rotina • Repetir somente se fatores de risco ou sintomas • Monitoramento com T4L, T3L, TSH. Anti-TPO e outros, conforme avaliação individual; • Avaliar o início de Levotiroxina; • Se necessário, realizar a teleconsultoria compulsória (<u>Item 4 deste protocolo</u>) em endocrinologia para avaliação do quadro e planejamento terapêutico, conforme Protocolo de Acesso de Endocrinologia do estado de SC - 2024. • Monitoramento com T4L, T3L, TSH e outros, conforme avaliação individual; • Avaliar início de Propiltiouracil; • Se necessário, realizar a teleconsultoria compulsória (<u>Item 4 deste protocolo</u>) em endocrinologia para avaliação do quadro e planejamento terapêutico, conforme Protocolo de Acesso de Endocrinologia do estado de SC - 2024.
				Importante: Conforme Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional (<u>Item 3</u> deste protocolo), apenas tireoidopatias (hipotireoidismo e hipertireoidismo) como condições prévias à gestação poderão ser encaminhadas ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco.	
X			PCR para clamídia e gonococo Solicitar este exame apenas para gestante $\leq$ 30 anos ou >30 anos com fatores de risco, sendo eles: • Gestante com novo parceiro(a) sexual nos últimos 60 dias; • Múltiplos parceiros(as) sexuais simultâneos, parceiro(a) sexual com IST; • Não uso ou uso inadequado de preservativo; • Trabalhadoras do sexo; • Uso abusivo de álcool e outras drogas; • HIV positivo, história prévia de IST.	Negativo: • Não detectado para Chlamydia trachomatis; e • Não detectado para Neisseria gonorrhoeae Positivo: • Detectado para Chlamydia trachomatis; ou • Detectado para Neisseria gonorrhoeae; ou • Possível coinfeção.	• Manter orientações preventivas • Usar preservativo Clamídia Positiva: • Tratar com Azitromicina 1g VO dose única; • Tratar parceiro simultaneamente; • Repetir teste em 3-4 semanas; • Orientar abstinência sexual até cura; Gonorréia Positiva: • Tratar com Azitromicina 1g VO dose única + Ceftriaxona 500mg IM dose única, • Tratar parceiro simultaneamente, • Repetir teste em 3-4 semanas, • Investigar outras ISTs

EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL E CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DE EXAMES CONFORME PERÍODO GESTACIONAL

1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)	EXAMES DE ROTINA	RESULTADO	CONDUTAS
X	X	X	Sorologia para toxoplasmose (IgM e IgG) Seguir orientações conforme link: Manual Técnico e Orientações sobre o Manejo Toxoplasmose, SES, 2025	Gestante soronegativa IgG (-) e IgM (-)	• Orientar para prevenção primária; • Repetir a sorologia de três em três meses.
				Gestante IgG (+) e IgM (-)	• Diagnosticar como Gestante Imune - doença antiga; • Não há necessidade de repetir sorologias; • Realizar orientações nutricionais.
				Gestante IgG (+) e IgM (+) <i>Atenção: Se IgM e IgG positivo - Possibilidade de infecção durante a gestação: o laboratório deve realizar o teste de avidéz para IgG na <u>mesma amostra de sangue</u></i>	• Gestação < 16 semanas (Realizar Teste de Avidéz): ◦ Avidéz forte: infecção adquirida antes da gestação, não há necessidade de mais testes ou tratamento; ◦ Avidéz fraca: possibilidade de infecção adquirida na gestação, iniciar espiramicina imediatamente. • Gestação > 16 semanas (Não é indicado realizar Teste de Avidéz): ◦ Antes da 30ª semana - Iniciar espiramicina; ◦ Após a 30ª semana - Iniciar esquema tríplice.
				Gestante IgG (-) e IgM (+)	• Infecção muito recente ou IgM falso positivo: iniciar espiramicina imediatamente; • Repetir a sorologia em três semanas: ◦ IgG positivo: confirma-se a infecção; ◦ IgG negativo: suspender a espiramicina, prevenção primária e repetir sorologia de três em três meses e no momento do parto.
				Atenção: • Confirmada a infecção aguda antes da 30ª semana, deve-se manter a espiramicina via oral (1 g → 3.000.000 UI de 8/8 horas) continuamente até o final da gravidez; • Se a infecção se der após a 30ª semana, recomenda-se instituir o tratamento tríplice materno: ◦ Pirimetamina (25 mg), de 12/12 horas, por via oral; ◦ Sulfadiazina (1.500 mg), de 12/12 horas, por via oral; e ◦ Ácido folínico (10 mg/dia) – este é imprescindível para a prevenção de aplasia medular causada pela pirimetamina; • Em gestantes com infecção aguda, referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, realizando USG mensal para avaliar alterações morfológicas fetais e mantendo cuidado compartilhado na APS; • Se a idade gestacional > 30 semanas, não é necessário avaliar o Líquido amniótico. Inicia-se esquema tríplice pela alta probabilidade de infecção fetal. • Notificar todos os resultados de IgM positivo, Toxoplasmose adquirida e congênita.	
X	X	X	Parcial de urina tipo I; e Urocultura e antibiograma	Proteinúria: “Traços” e PA menor que 140 x 90 mmHg e ausência de sinais de pré-eclâmpsia	• Repetir em 15 dias; • Mantendo o resultado, realizar Teleconsultoria no Pré-Natal (Item 4 deste protocolo) • Monitorar o nível pressórico.
				Proteinúria: “Traços” e PA maior que 140 x 90 mmHg ou proteinúria “Maciça”	• Referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS.
				Piúria / Suspeita de pielonefrite (ITU + febre) / Urocultura com múltiplas resistências	• Referenciar a gestante para a <u>emergência obstétrica</u> da maternidade, com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito/impresso em mãos, relatando o atendimento; • Se for isolado o estreptococo do grupo B em urocultura, é de suma importância destacar essa informação no Cartão da Gestante, uma vez que se trata de indicação de antibioticoterapia intraparto.
				Histórico de pielonefrite na gravidez / Litíase + ITU de repetição nesta gravidez (2 episódios em 6 meses ou 3 desde o início da gravidez)	• Referenciar ao <u>Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco</u>, mantendo cuidado compartilhado na APS; • Até o agendamento no Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, tratar a gestante para infecção do trato urinário (ITU) empiricamente; • Solicitar o exame de parcial de urina tipo I e urocultura 7 dias após o término do tratamento para controle da cura;

EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL E CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DE EXAMES CONFORME PERÍODO GESTACIONAL

1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)	EXAMES DE ROTINA	RESULTADO	CONDUTAS
X	X	X	Parcial de urina tipo I; e Urocultura e antibiograma	Hematúria	- Referenciar a gestante para a <u>emergência obstétrica</u> da maternidade, com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito/impresso em mãos, relatando o atendimento; - Se for isolada, uma vez que tenha sido excluído sangramento genital, se necessário, realizar Teleconsultoria em Nefrologia (Item 4 deste protocolo);
				Cilindrúria	Se necessário, realizar Teleconsultoria em Nefrologia (Item 4 deste protocolo);
				Outros elementos	Não necessitam de condutas especiais.
X	X	X	Teste Rápido para HIV <i>Solicitar Sorologia Anti-HIV somente na ausência de TR</i>	TR reagente (T1 e T2) ou sorologia reagente	- Realizar aconselhamento pós-teste e encaminhar a gestante, se necessário, para o seguimento na UAE e/ou referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS; - Realizar a Notificação Compulsória inserindo o CID referente ao agravo no SIG-SaúdeTech: - B24 - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada. - Encaminhar parceiro sexual para triagem sorológica (se autorizado pela gestante); - Orientar o uso do preservativo.
				TR negativo ou sorologia não reagente	- Realizar aconselhamento pós-teste; - Repetir exame no 2º e 3º trimestres.
X	X	X	Teste Rápido para Sífilis <i>Solicitar Sorologia para Sífilis (VDRL) somente:</i> - Para gestante com história prévia de sífilis e comprovação de tratamento; ou - TR reagente no momento da consulta para iniciar controle de cura.	TR reagente	- Instituir tratamento imediato: tratar a gestante e a parceria conforme classificação clínica - Realizar a Notificação Compulsória inserindo o CID referente ao agravo no SIG-SaúdeTech: - O98.1 - Sífilis complicando a gravidez, o parto e o puerpério; ou - A52 - Sífilis tardia - Anotar o tratamento na carteira de pré-natal; - Solicitar VDRL mensal para monitoramento e controle de cura; - Encaminhar parceiro sexual para triagem sorológica (se autorizado pela gestante); - Orientar o uso do preservativo.
				TR reagente e VDRL não reagente <i>Atenção: Nesta situação, o laboratório é orientado a realizar um terceiro teste treponêmico (com a mesma amostra) com metodologia diferente do primeiro, para confirmação diagnóstica.</i>	- Instituir tratamento imediato; - Pesquisar história de tratamento anterior e, se adequado, o tratamento pode ser descontinuado (avaliar possibilidade de janela imunológica e/ou cicatriz); - Repetir VDRL após 30 dias para confirmar persistência da negatividade.
				TR não reagente ou VDRL não reagente	Repetir o exame no 2º e 3º trimestres, no momento do parto e em caso de abortamento.
				VDRL Reagente na ausência do insumo TR	Realizar tratamento, conforme linha da Sífilis.
				Atenção: Para solicitação de exame de VDRL, algumas orientações do laboratório deverão ser seguidas, conforme SEI 25.0.031644-5 - Orientações para solicitação de exames laboratoriais para Sífilis no sistema SIG-SaúdeTech, na disponibilidade de Teste Rápido para Sífilis: - As solicitações acompanhadas do descritivo "monitoramento" terão por finalidade o monitoramento da resposta ao tratamento, bem como o controle da cura. Portanto, estes procedimentos deverão ser solicitados somente para os usuários que estão em acompanhamento do tratamento, não sendo necessário justificativa para esta solicitação; - Os procedimentos acompanhados do descritivo "diagnóstico" terão finalidade diagnóstica, sendo obrigatório o preenchimento do resultado reagente do Teste Rápido na requisição de exames laboratoriais; - Nos casos em que o usuário apresentar sintomas clínicos que sugerem infecção pelo <i>Treponema pallidum</i> e o resultado do Teste Rápido for "não reagente", o procedimento VDRL com finalidade diagnóstica poderá ser solicitado mediante a seguinte justificativa: "TR não reagente com sintomas clínicos".	

EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL E CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DE EXAMES CONFORME PERÍODO GESTACIONAL

1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)	EXAMES DE ROTINA	RESULTADO	CONDUTAS
X	X	X	Teste rápido ou sorologia para: - Hepatite B (HBsAg) - Hepatite C (Anti-HCV)	Reagente / Positivo	- Realizar aconselhamento pós-teste e referenciar a UAE com o laudo do TR, mantendo cuidado compartilhado na APS e no serviço de referência da UAE conforme rotina do mesmo; - Se houver necessidade, referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo o acompanhamento na APS e/ou UAE; - Realizar a Notificação Compulsória inserindo o CID referente ao agravo no SIG-SaúdeTech, e havendo necessidade, referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, B18.1 - Hepatite viral crônica B sem agente Delta; e/ou B18.2 - Hepatite viral crônica C
				Não Reagente / Negativo	- Realizar aconselhamento pós-teste e vacinar a gestante (hepatite B), caso ela não tenha sido vacinada anteriormente; - Repetir exame no 2º e 3º trimestre.
X	X	X	Sorologia para HTLV	Negativo	- Realizar aconselhamento pós-teste; - Repetir exame no 2º e 3º trimestre.
				Positivo Atenção: Casos que necessitem de teste confirmatório de HTLV, o laboratório municipal entrará em contato com o LACEN para verificar a viabilidade de sua realização.	- Realizar a Notificação Compulsória inserindo o CID referente ao agravo no SIG-SaúdeTech: Z22.6 - Portador de Infecção pelo vírus T-linfotrópico tipo 1 - Aconselhar inibição da lactação; - Encaminhar parceiro sexual para triagem sorológica; - Orientar o uso do preservativo. - Realizar aconselhamento pós-teste e, se houver necessidade, referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo o acompanhamento na APS.
				Importante: Conforme Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional (Item 3 deste protocolo), gestantes com diagnóstico confirmado de HTLV-1 e HTLV-2 e assintomáticas mantêm o pré-natal e seguimento na APS de acordo com o guia do Ministério da Saúde, disponível no link Guia de Manejo Clínico da Infecção por HTLV . Se identificados sintomas relacionados à infecção, como por exemplo sintomas intermediários da mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical (HAM/TSP), bexiga neurogênica, uveíte e coinfeções, como tuberculose pulmonar e estrogiloidiase grave, encaminhar para a Infectologia, via SIG SaudeTech.	
X			Teste de Eletroforese de Hemoglobina POP nº 31 - Teste de Eletroforese de Hemoglobina - Pesquisa de Hemoglobinopatias em Gestantes - Teste Mãe Catarinense (Processo SEI nº SEI 20.0.161521-8)	Doença Falciforme: • Hb SS; ou • Hb SC	Encaminhar ao especialista hematologista via SIG-Saudetech (teleconsultoria compulsória - Item 4 deste protocolo) e referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo o acompanhamento na APS.
				Sem Doença Falciforme: • Hb AA (padrão normal); ou • Hb AS: Traço falciforme; ou • Hb AC: Traço falciforme.	- Quando há Traço Falciforme, informar e orientar a gestante sobre a condição. É sugerido que o pai também realize o teste de eletroforese de hemoglobina. - Quando a gestante e o pai do bebê são portadores de traço falciforme (Hb AS), a conduta no pré-natal é focada na orientação e no monitoramento dos riscos genéticos para a criança. - O diagnóstico da criança com a doença falciforme deve ser feito por meio do teste do pezinho, que é fundamental para o início precoce do acompanhamento com um hematologista, caso necessário.
X			Ultrassonografia (USG) obstétrica com medida de translucência nuchal (TN) Atenção: Realizada entre 11 a 14 semanas de gestação (Vide Item 2.5.2 deste protocolo)	Laudo alterado	- Realizar Teleconsultoria no Pré-Natal (Item 4 deste protocolo); ou - Encaminhar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco.

EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL E CONDUTAS FRENTE AOS RESULTADOS DE EXAMES CONFORME PERÍODO GESTACIONAL					
1º Tri (1 a 13 sem)	2º Tri (14 a 28 sem)	3º Tri (29 a 40 sem)	EXAMES DE ROTINA	RESULTADO	CONDUTAS
X	X		Ultrassonografia (USG) Morfológica realizada entre a 20ª e a 24ª semanas de gestação <i>Atenção: Para as gestantes com critério de risco (Vide Item 2.5.2 deste protocolo)</i>	Laudo alterado	- Realizar teleconsultoria (<u>Item 4 deste protocolo</u>) ou - Encaminhar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco.
X			Citopatológico do colo de útero	- A coleta do Papanicolaou está indicada para as mulheres acima de 25 anos, de acordo com o protocolo de rastreamento do câncer de colo de útero; - Pode ser realizado durante toda a gestação, mas, preferencialmente deve ser coletado na primeira avaliação do pré-natal; - Se forem identificadas alterações ou confirmação de lesão cancerígena, dar prosseguimento com encaminhamento para especialidade da Patologia do Colo do Útero, inserindo a solicitação para o Setor de Regulação Municipal, via SIG SaúdeTech.	
Se início de Pré-natal tardio			Solicitar os exames descritos na 1ª consulta do 3º Trimestre, mais a inclusão dos seguintes exames: - USG obstétrica inserindo justificativa; - Teste oral de tolerância à glicose com 75g (3 pontos: jejum, 1ªh e 2ªh). <i>Importante: não realizar em gestantes com DM pré-gestação e não solicitar glicemia de jejum.</i>	Vide resultados e condutas conforme descritos acima.	
Gestantes com mais de 40 semanas				- A partir de 40 semanas + 1 dia, a usuária deverá ser encaminhada para emergência obstétrica da MDV a cada 3 dias, com encaminhamento <u>escrito/impresso</u> constando as principais informações clínicas do pré-natal (IG, paridade, BCF, PA) e informações do exame físico na última consulta na UBSF. A usuária deve ser orientada a levar o Cartão da Gestante e os exames realizados; - A emergência obstétrica da MDV fará avaliação da vitalidade fetal e programação de internação para as devidas intervenções.	

Elaborado por: NGQ, 2025

2.5.2. Ultrassonografia

A realização de ultrassonografia durante a assistência ao pré-natal pode identificar diversos problemas passíveis de intervenção oportuna. Por outro lado, é importante ressaltar que não há evidências que relacionem diretamente a realização rotineira de USG com melhores desfechos perinatais.

A ultrassonografia precoce pode auxiliar no diagnóstico oportuno das gestações múltiplas, na datação mais acurada da idade gestacional, reduzindo o número de induções por gestação prolongada, além de evidenciar a viabilidade fetal.

A seguir são descritas as indicações para a ultrassonografia no município, conforme orientação disponibilizada no Processo SEI nº 20.0.037538-8.

2.5.2.1. Indicação Ultrassonografia Obstétrica

- Recomenda-se, de rotina, um exame ultrassonográfico obstétrico, via abdominal, durante a gestação de baixo risco, a ser realizado entre a 11^a até 14^a semana de gestação
- O agendamento do exame será randômico, realizado pelo profissional solicitante (médico ou enfermeiro) no momento da consulta;
- O objetivo primordial é a avaliação da translucência nuchal (acima de 14 semanas, a solicitação deverá ser justificada e encaminhada via SIG-SaúdeTech para a Central de Regulação);
- A ultrassonografia (USG) em gestações abaixo de 10 semanas não constitui exame de rotina durante o pré-natal, devendo ser solicitado apenas nos casos de:
 - Sangramento vaginal de primeiro trimestre;
 - Na ausência de alterações hemodinâmicas e/ou;
 - Sinais de abdômen agudo;
 - Quando houver indicação de USG antes de 10 semanas, o exame deverá ser solicitado exclusivamente por médico e agendado sob regulação (prioridade P1 – altíssima), sendo a via endovaginal recomendada nesses casos.

2.5.2.2. Indicação de Ultrassonografia Morfológica

- Solicitado entre 20ª e 24ª semana gestacional, via SIG SaudeTech para a Central de Regulação Municipal, onde os médicos reguladores farão a regulação conforme prioridade clínica e dentro dos critérios de risco, conforme Processo SEI nº 20.0.037538-8;
- A solicitação de USG morfológico de 2º trimestre deverá ser realizada para as gestantes com critérios de inclusão descritos no Quadro 10 abaixo.

Quadro 10. Critérios de inclusão para USG morfológico

RELACIONADOS À GESTAÇÃO ATUAL
• Extrema idade materna: abaixo de 15 anos e acima de 40 anos; • Rastreamento positivo (alteração da TN no USG de 1º trimestre); • Gestante com DM/DMG; • Gestação múltipla; • Infecção materna aguda com possível repercussão fetal (Zika, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, herpes simplex); • Exposição a drogas e/ou agentes ambientais (ex. radiação) potencialmente teratogênicos; • USG obstétrica com suspeita de malformação fetal; • USG obstétrica sugestiva de restrição do crescimento fetal.
HISTÓRIA PREGRESSA
• Antecedente de malformação fetal; • História familiar de malformações fetais; • Abortamento habitual.

Fonte: Regulação -SES/Joinville, 2020 (Processo SEI nº 20.0.037538-8)

Importante: A **datação da idade gestacional** por ultrassonografia deverá sempre ser baseada na 1ª USG realizada e nunca ser recalculada com USG posteriores, sendo que, quanto maior o tempo de gestação, maior a margem de erro no cálculo da IG pelo USG em comparação com a DUM confiável. No primeiro trimestre, o desvio esperado no cálculo da idade gestacional é de três a sete dias. **Se a DUM estiver dentro da variação esperada, considerá-la para cálculo e se a diferença for maior, considerar a USG.**

2.6. Plano de Parto

O plano de parto no SUS é um instrumento de comunicação e autonomia da gestante, no qual ela expressa seus desejos e preferências para o parto, nascimento e pós-parto, com o apoio dos profissionais de saúde. A equipe deve acolher e discutir esse documento de forma respeitosa, garantindo que a mulher seja protagonista de seu parto e que o planejamento seja seguido sempre que a condição clínica permitir.

Dialogar sobre as expectativas da gestante e informar sobre as rotinas e

evidências científicas é essencial para humanizar o parto e evitar a violência obstétrica, fortalecendo a relação de confiança entre a mulher e a equipe de saúde.

Os profissionais da APS devem orientar e estimular a gestante a construir seu plano de parto (Processo SEI nº 22.0.356882-2).

3. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL

A estratificação de risco gestacional tem como objetivo indicar quais mulheres têm maior probabilidade de apresentar eventos adversos à saúde, possibilitando a atenção certa, no lugar certo, com custo certo e com qualidade certa, garantindo a segurança da gestante e da criança.

Para a classificação do risco gestacional, as equipes de saúde devem utilizar o [Instrumento de Classificação de Risco Gestacional do Estado de Santa Catarina](#), disponível no Processo SEI nº 20.0.022906-3, que permite a estratificação da gestação em: risco habitual, médio e alto risco, conforme [Quadro 11](#).

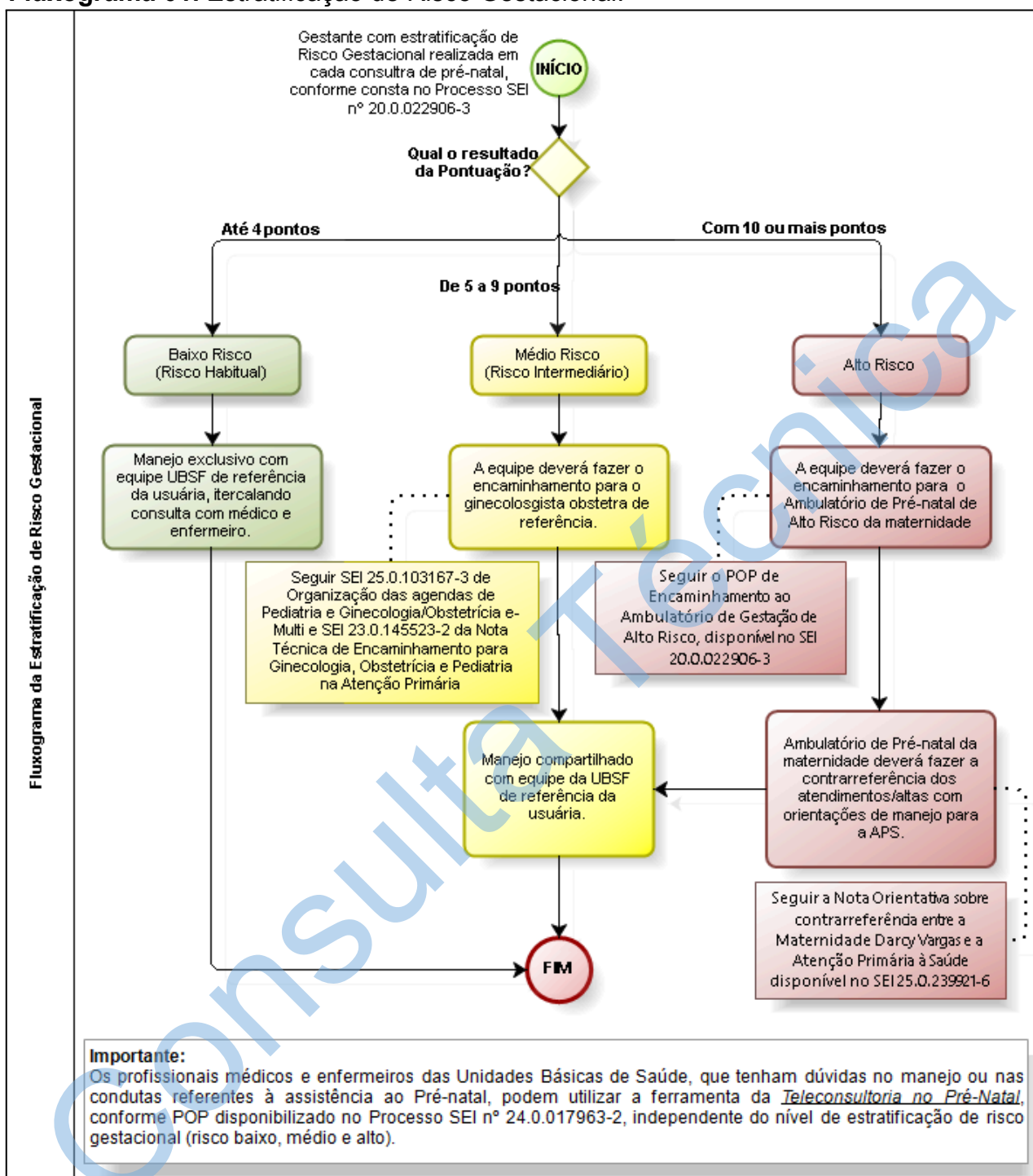
Quadro 11. Classificação de risco gestacional e códigos dos procedimentos da consulta de pré-natal

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL		
PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSULTA DE PRÉ-NATAL
Até 4 pontos	Baixo Risco (Risco Habitual)	0301010110 - PM Consulta Pre-Natal (utilizar em <u>todas</u> as consultas).
5 a 9 pontos	Médio Risco	0301010110 - PM Consulta Pre-Natal (utilizar em <u>todas</u> as consultas); 99980435 - PM Pré-Natal de Médio Risco (utilizar <u>uma única vez</u> no momento da estratificação).
10 ou mais pontos	Alto Risco	0301010110 - PM Consulta Pre-Natal (utilizar em <u>todas</u> as consultas); - Para identificar Pré-Natal de Alto Risco utilizar os seguintes códigos: Enfermeiros: CIAP W84 - Gravidez de alto risco; Médicos: CID Z35 para pré-natal de alto risco (Supervisão de gravidez de alto risco).
Importante: - Independente do nível de atendimento de risco (baixo, médio e alto) a gestante sempre deverá ser assistida na APS; - A <u>estratificação de risco gestacional</u> deve ser realizada em <u>todos os atendimentos</u>, ou seja, na primeira consulta e em todas as subseqüentes programadas ou, sempre que for identificado um fator de risco; - Uma vez diagnosticada a gestante como de maior risco para complicações, ela não volta a ser de risco habitual na mesma gestação; - O código <u>Consulta Pre-Natal - 0301010110</u> deverá ser utilizado em <u>todas as consultas</u> da gestante, independente do resultado da estratificação de risco; - O código <u>PM Pré-Natal de Médio Risco - 99980435</u> deverá ser utilizado <u>uma única vez</u> e apenas quando a gestante for estratificada como de médio risco.		



O fluxograma 01 detalha o processo desta estratificação de risco gestacional:

Fluxograma 01. Estratificação de Risco Gestacional.



Elaborado por: NGQ, 2025

3.1. Gestante de Baixo Risco (Risco Habitual) - Até 4 Pontos

A gestante de Baixo Risco (Risco Habitual) deve ser acompanhada pela equipe da APS durante toda a assistência ao pré-natal com consultas intercaladas entre médico e enfermeiro, conforme Quadro 07 deste protocolo.

3.2. Gestante de Médio Risco (Risco Intermediário) - 5 a 9 Pontos

A gestante de Médio Risco (risco intermediário) deve ser acompanhada pela equipe de APS durante toda a assistência ao pré-natal com consultas médicas e de enfermagem e avaliação do especialista (ginecologista obstetra - GO), quando necessário.

Toda gestante estratificada como de médio risco, deverá ser inserida no código de procedimento do Sistema SIG SaudeTech como: 99980435 - PM Pré-Natal de Médio Risco (utilizar **uma única vez** no momento da estratificação).

O encaminhamento ao GO deverá seguir as orientações constantes no Processo SEI nº 25.0.103167-3 - Organização das agendas de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia e-Multi, além da Nota Técnica 004/2023/DTE - Encaminhamento para Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria na Atenção Primária (Processo SEI nº 23.0.145523-2).

3.3. Gestante de Alto Risco - 10 ou Mais Pontos

A gestante de Alto Risco deve ser atendida pela equipe de APS e encaminhada obrigatoriamente para o Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco (PNAR) da Maternidade Darcy Vargas via Central de Regulação do Município utilizando o sistema de informação SIG-SaúdeTech, conforme **POP nº 59 - Encaminhamento ao Ambulatório de Gestação de Alto Risco da Maternidade Darcy Vargas** (Processo SEI nº 20.0.022906-3).

Importante:

- Gestantes referenciadas ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco deverão manter o **acompanhamento compartilhado com a Atenção Primária (consultas intercaladas entre médicos e enfermeiros)** e com a **MDV**.
- As gestantes referenciadas ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco para **acompanhamento nutricional**, deverão manter este cuidado **exclusivamente com a equipe de Nutricionistas da MDV**, conforme orientações do documento SEI 27631977 - **Orientações sobre acompanhamento nutricional das gestantes de alto risco na Maternidade Darcy Vargas (MDV)**.

4. TELECONSULTORIAS

4.1. Teleconsultoria no Pré-Natal

A Teleconsultoria no Pré-Natal, é disponibilizada aos profissionais **Médicos e Enfermeiros** da SMS de Joinville que tenham dúvidas no manejo ou nas condutas referentes à assistência do Pré-natal e faz parte do fluxo assistencial da usuária, conforme **POP nº 42 - Acesso à Teleconsultoria no Pré-Natal** (Processo SEI nº 24.0.017963-2).

O uso da teleconsultoria aumenta a resolubilidade da APS, diminui os encaminhamentos desnecessários e, mesmo quando o encaminhamento é necessário, ele torna-se mais qualificado (por exemplo, os exames que serão necessários já podem ser solicitados, otimizando-se a primeira consulta na atenção especializada).

Todas as informações da solicitação, bem como a resposta do teleconsultor, devem ser registradas no prontuário eletrônico da usuária e no Cartão da Gestante.

Importante: Quando os critérios de classificação de risco já identificarem um Pré-Natal de Alto Risco, não é necessário realizar a teleconsultoria. O encaminhamento deverá seguir o **POP nº 59 - Encaminhamento ao Ambulatório de Gestação de Alto Risco da Maternidade Darcy Vargas** (Processo SEI nº 20.0.022906-3).

4.2. Teleconsultoria em Especialidades

Para gestantes que necessitem de seguimento com especialista, e que não se enquadrarem nos critérios de Alto Risco (Processo SEI nº 20.0.022906-3), o encaminhamento às consultas especializadas via SIG-SaudeTech pode ser feito pelo médico assistente, com descrição do quadro clínico, classificação internacional de doenças (CID) que justifique o encaminhamento e os resultados de exames prévios (quando houver) relacionados ao quadro clínico, para otimizar a avaliação e regulação da classificação de critérios de risco.

O município também possui, além de Acesso à Teleconsultoria no Pré-Natal (Processo SEI nº 24.0.017963-2), a disponibilidade de Teleconsultoria em outras especialidades, como opção para o auxílio no manejo das usuárias via plataforma. A lista de especialidades pode ser acessada diretamente na plataforma via link [Telessaúde](#).

Dentre elas encontram-se disponíveis:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| → Cardiologia*; | → Neurologia*; |
| → Endocrinologia*; | → Obstetrícia; |
| → Hanseníase; | → Ortopedia adulto e infantil; |
| → Hematologia; | → Pneumologia adulto/infantil; |
| → Hepatite B e C; | → Psiquiatria adulto e infantil*; |
| → HIV; | → Reumatologia; |
| → Infectologia pediátrica; | → Sífilis; |
| → Nefrologia adulto e infantil; | → Tuberculose. |

**As especialidades de endocrinologia, cardiologia, psiquiatria e neurologia são compulsórias para a necessidade de encaminhamento à referida especialidade.*

Todas as informações da solicitação, bem como a resposta do teleconsultor, devem ser registradas no prontuário eletrônico da usuária e no Cartão da Gestante.

5. MANEJO DE SITUAÇÕES ESPECIAIS NA GESTAÇÃO

A morbimortalidade materna, fetal e infantil está diretamente relacionada a morbidades durante a gestação e, entre as morbidades mais prevalentes na gestação, e que necessitam de um cuidado especial, destacam-se:

- Doença hipertensiva;
- Diabetes mellitus;
- Infecção do trato urinário (ITU);
- Sífilis;
- Doença periodontal;
- Tromboembolismo.

Importante: A Maternidade Darcy Vargas não dispõe de atendimento especializado para patologias não relacionadas à gestação, e o encaminhamento para o **Ambulatório de Alto Risco Gestacional** deve ser feito apenas conforme critérios do Instrumento de Classificação de Risco, descrito no Item 3 deste protocolo.

Dentro das situações especiais na gestação, é importante observar os cuidados odontológicos e garantir o acesso a este atendimento conforme descrito no Item 5.5 - Cuidado Periodontal na Gestação e ainda, o cuidado das gestantes com queixas possivelmente relacionadas ao trabalho, garantindo o acesso ao serviço especializado nestas demandas, conforme Item 5.7 - Gestantes com Agravos à Saúde Possivelmente Relacionados ao Trabalho.



5.1. Doença Hipertensiva na Gravidez

A medida da pressão arterial é recomendada na consulta pré-concepcional e em todas as consultas do pré-natal, pois a melhor estratégia para diagnosticar a hipertensão na gestação é a detecção precoce da pressão arterial anormal.

Define-se hipertensão na gravidez como pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, em pelo menos duas aferições, após intervalo de repouso de 15 minutos.

A adequação de drogas, o acompanhamento nutricional e dietético e a avaliação do comprometimento cardíaco e renal são medidas importantes para se estabelecer prognóstico em gestação futura, sendo que mulheres hipertensas que engravidam têm maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia/eclâmpsia. O **POP nº 01 - Como Manejar as Urgências Hipertensivas na Gravidez** (Processo SEI nº 24.0.285540-6) detalha o manejo destas usuárias.

Orientações Gerais:

- O **tratamento** farmacológico deve seguir o preconizado pelo Ministério da Saúde (disponível no link [Manual da Gestação de Alto Risco](#)) e em conformidade com a *Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME* (Processo SEI nº 20.0.109264-9);
- O estilo de vida saudável com controle da dieta, peso e atividade física deve sempre ser aconselhado, pois reduz o risco de diabetes e de doenças cardiovasculares no futuro;
- Para usuárias com histórico de **hipertensão crônica prévia e descompensada**, encaminhar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco (PNAR) (Processo SEI nº 20.0.022906-3), para cuidado compartilhado;
- As equipes de saúde devem monitorar as mulheres após o parto. Após a alta, a MDV fará a contrarreferência de todas as altas (gestante, puérpera e RN) para a Unidade de Saúde Digital (USD) que promoverá o agendamento conjunto da puérpera e do bebê, até o 5º dia de vida, para continuidade do cuidado, conforme:
 - **Nota Orientativa Conjunta nº 21/2025 - DGE/DAP/MDV** - Orientações da Contrarreferência da Maternidade Darcy Vargas (MDV) para a Atenção Primária à Saúde (APS) para o agendamento de consultas de Gestante, Puérpera e RN residentes em Joinville (Processo SEI nº 25.0.239921-6); e
 - **Nota Orientativa Conjunta nº 25/2025 - SES.DGE/DAP** - Orientações para abertura de agenda pela Atenção Primária à Saúde (APS) para agendamento das Contrarreferências da Maternidade Darcy Vargas (MDV) pela Unidade de Saúde Digital (USD) (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

Na rotina de avaliação das gestantes com relação às doenças hipertensivas na gravidez, é importante que os edemas da gestação sejam avaliados de maneira cuidadosa, conforme o Quadro 12.



Quadro 12. Avaliação e Interpretação de Edema na Gestação

CARACTERÍSTICAS	CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES A SEREM REALIZADAS
Edema presente somente no tornozelo, sem alteração de pressão Arterial ou aumento de peso súbito	+ / +++	• Verificar se o edema está relacionado com a atividade laboral ou a posição que a gestante permanece maior parte do seu tempo; • Verificar o calçado; • Verificar temperatura e estação do ano.
Edema presente em membros inferiores, com alteração de Pressão Arterial e aumento de peso	++ / +++	• Orientar repouso em decúbito lateral esquerdo; • Verificar a presença de sinais ou sintomas de pré-eclâmpsia grave e interrogue a gestante sobre os movimentos fetais; • Marcar retorno semanal na ausência de sintomas; • Realizar interconsulta e agendar consulta com médico da Unidade; • Caso haja hipertensão, a gestante deve ser encaminhada ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco.
Edema generalizado (face, tronco e membros) ou que já se mostra presente quando a gestante acorda acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso	+++ / +++	• Gestante considerada de risco em virtude de suspeita de pré-eclâmpsia ou outras intercorrências; • A gestante deve ser avaliada pelo médico da Unidade e encaminhada ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco.

Fonte: Cadernos de Atenção Básica, nº 32 - Atenção ao pré-natal de baixo risco.

A profilaxia com Carbonato de cálcio e Ácido Acetilsalicílico (AAS) é de extrema importância para prevenir síndromes hipertensivas e as orientações para esta rotina estão descritas nos Itens 5.1.1.1 e 5.1.1.2.

5.1.1. Profilaxia de Doença Hipertensiva na Gravidez

5.1.1.1. Profilaxia com Carbonato de Cálcio

A suplementação de cálcio na gestação é recomendada para **todas as gestantes a partir da 12ª semana de gravidez até o parto**, com o objetivo de prevenir síndromes hipertensivas, como a pré-eclâmpsia, sendo que o período gestacional máximo para o início desta prescrição é de **20 semanas**, sendo que após este período não há mais indicação.

No atendimento de qualquer gestante com mais de 12 semanas, confirmar se iniciou a profilaxia. Caso negativo, realizar a prescrição de Carbonato de Cálcio:

- Carbonato de Cálcio 500 mg - 1 comprimido via oral a cada 12 horas.

Atenção: A apresentação associada disponível no elenco básico de medicamentos poderá ser usada como alternativa, sendo: **Carbonato de Cálcio + Vitamina D3, 500 mg + 400 UI (1 comprimido via oral a cada 12 horas).**



5.1.1.2. Profilaxia Com Ácido Acetilsalicílico (AAS)

A indicação da profilaxia com AAS ocorrerá mediante a presença ou não de fatores de risco descritos no Quadro 13 abaixo.

Quadro 13. Fatores de Risco para a profilaxia com AAS

RISCO ALTO (Presença de apenas 1 fator de risco possui indicação de profilaxia)	RISCO MODERADO (Presença de 2 ou mais fatores de risco possui indicação de profilaxia)
• História de pré-eclâmpsia; • Gestação múltipla; • Obesidade (IMC $>30\text{kg/m}^2$); • Hipertensão arterial crônica; • Diabetes Tipo 1 ou 2; • Doença renal crônica; • Doenças autoimunes; • Gestação decorrente de reprodução assistida (FIV).	• Nuliparidade; • História familiar de pré-eclâmpsia (mãe/irmãs); • Idade ≥ 35 anos; • Intervalo >10 anos desde a última gestação; • Condição socioeconômica desfavorável; • Gravidez prévia com desfecho relacionado a disfunção placentária: descolamento prematuro, restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro, óbito fetal.

Fonte: Pré-eclâmpsia- Protocolo 2025. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2025

A indicação da profilaxia com AAS se dá com a **presença de um (1) fator de risco alto OU dois (2) fatores de risco moderado** (interromper com 36 semanas devido a risco de sangramento e ausência de benefício adicional), sendo indicado:

➤ AAS 100 mg - 1 comprimido via oral à noite.

5.1.2. Manejo das Síndromes Hipertensivas

5.1.2.1. Gestante com Menos de 20 Semanas:

- Se PA $\geq 140 \times 90 \text{mmHg}$ e $< 160 \times 110 \text{mmHg}$: Orientar **Monitorização Residencial da Pressão Arterial** (MRPA) e retorno em 7 (sete) dias;
- No retorno, se gestante mantiver PA $\geq 140 \times 90 \text{mmHg}$ e $< 160 \times 110 \text{mmHg}$, manter a **profilaxia com AAS e Carbonato de cálcio**;
- Se PA maior ou igual a 30% das medidas acima de $140 \times 90 \text{mmHg}$, iniciar também o hipotensor de manutenção (Metildopa 250mg: Dose Inicial 750mg com Dose Máxima 2000mg/dia);
- No momento da identificação do quadro de hipertensão crônica, solicitar exames de Função Renal, Eletrólitos, ECG e Proteinúria 24h;
- Se PA $\geq 160 \times 110 \text{mmHg}$: Realizar hidralazina com o objetivo de baixar PA entre 15-25%, conforme **POP nº 01 - Como Manejar as Urgências Hipertensivas na Gravidez** (Processo SEI nº 24.0.285540-6).



5.1.2.2. Gestante com Idade Gestacional Maior ou Igual a 20 Semanas

- **Se PA $\geq$ 160x110 mmHg:**
 - Avaliar a presença de sinais de alarme (Cefaleia, Fotofobia, Turvação visual, Edema em rosto e mão, Escotomas, Hiperreflexia, Náusea e/ou vômitos, Epigastralgia, Dor abdominal em hipocôndrio direito).
- **Se houver sinais de alarme:**
 - Considerar uma iminência de eclâmpsia e iniciar dose de ataque do Sulfato de Magnésio – MgSO₄ 10%, conforme **POP nº 01 - Como Manejar as Urgências Hipertensivas na Gravidez** (Processo SEI nº 24.0.285540-6).
- **Se NÃO houver sinais de alarme:**
 - Aferir a PA novamente após 15 minutos de repouso;
 - Se a PA se mantiver $\geq$ 160x110 mmHg, iniciar Sulfato de Magnésio – MgSO₄ 10%, conforme **POP nº 01 - Como Manejar as Urgências Hipertensivas na Gravidez** (Processo SEI nº 24.0.285540-6).

Importante:

Se PA $\geq$ 140x90 mmHg e $<$ 160x110mm: Orientar a gestante a se dirigir a emergência da MDV para avaliação laboratorial e vitalidade fetal com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito/impresso em mãos, relatando o atendimento.

Se a usuária estiver com mais de 20 semanas de gravidez e PA $\geq$ 140x90 mmHg, ou seja, sem pico pressórico, mas COM sinais de alarme, uma iminência de eclâmpsia deverá ser considerada também:

Iniciar Sulfato de Magnésio, mesmo se não estiver em pico pressórico, conforme **POP nº 01 - Como Manejar as Urgências Hipertensivas na Gravidez** (Processo SEI nº 24.0.285540-6).

5.1.3. Acompanhamento Pós-Parto da Gestante com Doença Hipertensiva na Gravidez

5.1.3.1. Puérpera com Hipertensão Crônica sem Pré-Eclâmpsia Sobreposta na Gestação ou com Síndromes Hipertensivas Na Gestação que não Necessitou Uso de Medicação

No momento da alta a MDV fará a contrarreferência para a Unidade de Saúde Digital (USD), orientando o agendamento e atendimento conjunto da puérpera e do recém-nascido entre o 3º até o 5º dia do pós-parto ou da alta hospitalar e orientações específicas com relação ao manejo desta usuária (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

As puérperas de cesariana serão orientadas a retornar para retirada de pontos conforme prescrição médica.



5.1.3.2. Puérpera com Diagnóstico de Pré-Eclâmpsia na Gestação

A puérpera permanecerá em acompanhamento ambulatorial na MDV e receberá alta somente após manutenção de níveis pressóricos dentro da normalidade e após a suspensão da medicação antihipertensiva.

As orientações para o seguimento do cuidado estarão descritas de forma detalhada na contrarreferência da MDV para a Unidade de Saúde Digital (USD) (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

5.2. Diabetes Mellitus na Gravidez

No rastreio realizado durante a consulta de pré-natal, podemos nos deparar com casos de:

- Diabetes Mellitus Pré-Gestacional;
- Diabetes Mellitus Diagnosticada na Gestação; e
- Diabetes Mellitus Gestacional.

Para identificação correta, será necessário realizar o diagnóstico diferencial, conforme Quadro 14 a seguir.

Quadro 14. Diagnóstico Diferencial de Hiperglicemia da Gestação

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPERGLICEMIA DA GESTAÇÃO*	
Diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) <u>prév</u>io à <u>gestação</u> em acompanhamento	• Diagnóstico prév
Diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) <u>durante</u> a <u>Gestação</u>	• Glicemia de jejum ≥ 126; ou • Glicemia ao acaso** $\geq 200\text{mg/dL}$; ou • HbA1c $\geq 6,5\%$
Diagnóstico de Diabetes Mellitus <u>Gestacional</u> (DMG)	• Glicemia de jejum = 92 a 125mg/dl; ou • TOTG após 24ª semana: ◦ Glicemia de Jejum = 92 a 125mg/dl; ou ◦ Glicemia 1h $\geq 180\text{mg/dL}$; ou ◦ Glicemia 2h = 153 a 199mg/dL.
*As orientações quanto a realização dos exames de rotina de pré-natal e as condutas frente aos resultados de exames conforme período gestacional, estão descritas no <u>Quadro 09</u>. **Glicemia ao acaso: medição do nível de glicose (açúcar) no sangue realizada a qualquer momento do dia, independentemente do tempo desde a última refeição.	

Fonte: NGQ 2025 - Adaptado da Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes 2025.



Orientações Gerais:

- Quando houver a necessidade de avaliação com a especialidade de **Endocrinologia**, é obrigatório que este encaminhamento seja feito através de teleconsultoria (Item 4 deste protocolo), realizada através do *link* do sistema de Telemedicina. O especialista poderá orientar condutas clínicas ao médico da APS, o que pode resultar em um manejo clínico mais breve ou poderá orientar o encaminhamento, via SIG SaúdeTech, para consulta presencial com Endocrinologista;
- O município também possui a disponibilidade da Teleconsultoria no Pré-Natal disponibilizado (Processo SEI nº 24.0.017963-2), como opção para o auxílio no manejo das usuárias;
- As mulheres diagnosticadas com DMG, não compensada com dieta e com necessidade de insulinoterapia ou DM descompensada devem ser encaminhadas para seguimento no Ambulatório de Pré-natal de **Alto Risco** da maternidade conforme **POP nº 59 - Encaminhamento ao Ambulatório de Gestação de Alto Risco da Maternidade Darcy Vargas** (Processo SEI nº 20.0.022906-3);
- O **tratamento** farmacológico deve seguir o preconizado pelo Ministério da Saúde (disponível no *link* Manual da Gestação de Alto Risco) e em conformidade com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME (Processo SEI nº 20.0.109264-9);
- O estilo de vida saudável com controle da dieta, peso e atividade física deve sempre ser aconselhado, pois reduz o risco de diabetes e de doenças cardiovasculares no futuro;
- Todas as gestantes devem ser estimuladas a **amamentar**, pois a amamentação está associada à melhora na glicemia após o parto, podendo reduzir o risco de diabetes futuro nas mulheres com história de DMG;
- Aquelas com diabetes prévio à gestação, **após o parto**, podem necessitar de ajustes na dieta, nas doses de insulina e dos hipoglicemiantes orais, sendo que o uso de metformina, glibenclâmida e insulina é seguro e compatível com a amamentação e os métodos contraceptivos são os mesmos recomendados às mulheres não diabéticas;
- As equipes de saúde devem monitorar as mulheres após o parto. Após a alta, a MDV fará a contrarreferência de todas as altas (gestante, puérpera e RN) para a Unidade de Saúde Digital (USD) que promoverá o agendamento conjunto da puérpera e do bebê, até o 5º dia de vida, para continuidade do cuidado, conforme:
 - **Nota Orientativa Conjunta nº 21/2025 - DGE/DAP/MDV** - Orientações da Contrarreferência da Maternidade Darcy Vargas (MDV) para a Atenção Primária à Saúde (APS) para o agendamento de consultas de Gestante, Puérpera e RN residentes em Joinville (Processo SEI nº 25.0.239921-6); e
 - **Nota Orientativa Conjunta nº 25/2025 - SES.DGE/DAP** - Orientações para abertura de agenda pela Atenção Primária à Saúde (APS) para agendamento das Contrarreferências da Maternidade Darcy Vargas (MDV) pela Unidade de Saúde Digital (USD) (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

5.2.1. Acompanhamento Pós-Parto da Gestante com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) ou Diabetes Mellitus (DM)

Ainda que a tolerância à glicose se normalize rapidamente após o parto na maioria das mulheres, o risco de desenvolvimento de DM tipo 2 ou intolerância à glicose é significativo. A avaliação no pós-parto visa, além de diagnosticar DM tipo 2 precocemente, identificar mulheres que persistem com intolerância à glicose e que poderão se beneficiar com medidas para prevenção do diabetes.



São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de DM tipo 2 em mulheres com DMG:

- Glicemia em jejum na gestação acima de 100mg/dl;
- Etnia não branca;
- História familiar de DM tipo 2, principalmente materna;
- Ganho excessivo de peso durante e após a gestação;
- Obesidade;
- Obesidade abdominal;
- Dieta hiperlipídica;
- Sedentarismo;
- Uso de insulina na gestação.

5.2.2. Puérpera com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)

No momento da alta, a MDV fará a contrarreferência para a Unidade de Saúde Digital (USD), orientando o agendamento e atendimento conjunto da puérpera e do recém-nascido entre o 3º até o 5º dia do pós-parto ou da alta hospitalar.

Independentemente de usar ou não medicação durante a gestação, a orientação é a manutenção apenas com dieta após o parto e repetir o TOTG 45 dias após o parto (final do puerpério). Não há indicação de controle de HGT para usuárias DMG no puerpério.

E as orientações para o seguimento do cuidado estarão descritas de forma detalhada na contrarreferência da MDV para a Unidade de Saúde Digital (USD) (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

5.2.3. Puérpera com DM Prévia (DM1 e DM2)

No momento da alta, a MDV fará a contrarreferência para a Unidade de Saúde Digital (USD), orientando o agendamento e atendimento conjunto da puérpera e do recém-nascido entre o 3º até o 5º dia do pós parto ou da alta hospitalar.

Os ajustes nas medicações para usuárias com DM prévio deverão ocorrer conforme controle de HGT usual.

E as orientações para o seguimento do cuidado estarão descritas de forma detalhada na contrarreferência da MDV para a Unidade de Saúde Digital (USD) (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

5.3. Infecção do Trato Urinário (ITU) na Gestação

As ITUs estão associadas ao aumento da morbimortalidade materna, podendo ocasionar ruptura prematura de membranas, aborto, trabalho de parto prematuro,

corioamnionite, baixo peso ao nascer, infecção neonatal, além de serem uma das principais causas de septicemia na gravidez.

Além disso, há forte associação entre a bacteriúria assintomática na gestante e o desenvolvimento de pielonefrite aguda. A rotina de rastrear e tratar bacteriúria assintomática em todas as gestantes, diminui a incidência de Pielonefrite Aguda na gestação.

Os profissionais de saúde devem estar atentos para a realização dos exames de rotina e condutas referentes ao rastreamento de ITU (Quadro 09).

O Quadro 15 sugere a interpretação de sintomas relacionados a ITU.

Quadro 15. Interpretação de sintomas relacionados a ITU

SITUAÇÃO	SINTOMAS	CONDUTA
Gestante <u>Assintomática</u> com urocultura positiva	Assintomática.	- Realizar avaliação médica; - Tratar conforme Quadro 16; - Realizar urocultura em 7 a 10 dias após o tratamento.
Gestante <u>Sintomática</u>	Sintomas de ITU: - Dor ao urinar; - Dor suprapúbica; - Urgência miccional; - Aumento da frequência urinária; - Nictúria/enurese noturna; - Estrangúria; - Presença de sangramento visível na urina.	- Realizar avaliação médica; - Iniciar tratamento presumido imediato, conforme Quadro 16; - Realizar urocultura antes do início do tratamento; - Repetir urocultura em 7 a 10 dias após o tratamento.
Gestante com <u>qualquer</u> idade gestacional (IG) com suspeita de pielonefrite aguda	Sintomas sistêmicos: - Febre; - Taquicardia; - Calafrios; - Náuseas; - Vômitos; - Dor lombar, com sinal de Giordano positivo; - Dor abdominal.	- Encaminhar para a emergência obstétrica da maternidade, com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito ou impresso em mãos, relatando detalhadamente o atendimento e o motivo do encaminhamento.; - Após tratamento, iniciar profilaxia com antibiótico; - Urocultura mensal até o parto; - Após o parto realizar urocultura (avaliar necessidade de encaminhar ao urologista).

Elaborado: NGQ, 2025

O Quadro 16 apresenta os antibióticos de escolha para os tratamentos específicos em gestantes e disponíveis no elenco de medicamentos do município.

Quadro 16. Antibioticoterapia no tratamento da bacteriúria assintomática e ITU não complicada em gestantes

ANTIBIÓTICO	POSOLOGIA	OBSERVAÇÕES
Nitrofurantoína 100mg	01 cápsula de 6/6 horas por 7 dias	Evitar após a 36ª semana de gestação
Cefalexina 500mg	01 cápsula de 6/6 horas por 7 dias	
Importante: • Repetir urocultura 07 a 10 dias após o término do tratamento; • Verificar se o quadro de infecção urinária é recorrente ou de repetição; • No caso de um segundo episódio de bacteriúria assintomática ou ITU não complicada na gravidez, a gestante deverá ser encaminhada ao ginecologista de referência, que após avaliação inicial poderá manter o cuidado compartilhado com a Equipe de Saúde da Família, ou realizar a contrarreferência com sugestões do manejo, sendo que a qualquer momento esta gestante poderá ser encaminhada novamente.		

Elaborado: NGQ, 2025

5.3.1. Recidiva ou Reinfecção de ITU

Após o episódio inicial de ITU, existe o risco de infecções recorrentes, que caso aconteça, o tratamento deve ser repetido com base no resultado da urocultura.

Em caso de recorrência de 3 ou mais episódios da bacteriúria ou após pielonefrite aguda, está indicado o uso de profilaxia para evitar novos episódios de ITU, conforme o Quadro 17.

Quadro 17. Antibioticoterapia profilática em ITU recorrente e pielonefrite aguda

ANTIBIÓTICO PROFILÁTICO	POSOLOGIA	OBSERVAÇÕES
Cefalexina 500mg	1 vez à noite	Até o parto
Nitrofurantoína 100mg	1 vez à noite	Até o parto, suspender na última semana por risco de hemólise do RN

Elaborado: NGQ, 2025

A gestante também deve ser acompanhada e orientada quanto à:

- Tratamento adequado das leucorreias vaginais (corrimento);
- Orientação para correta higiene genital e anal;
- Aumento da ingestão de líquidos;
- Urinar frequentemente.

5.3.2. Queixas Urinárias Comuns da Gestação sem Necessidade de Intervenção

A provável compressão da bexiga pelo útero gravídico, diminuindo a capacidade volumétrica, ocasiona a polaciúria (aumento do ritmo miccional) e a nictúria (aumento do ritmo miccional no período de sono), que se acentua à medida que a gravidez progride, dispensando tratamento e cuidados especiais.



5.4. Sífilis na Gestação

Todas as orientações relacionadas ao manejo da Sífilis em gestantes estão descritas na **Linha de Cuidado Para a Atenção Integral à Pessoa com Sífilis** (Processo SEI nº 23.0.299742-0).

5.4.1. Tratamento da Sífilis na Gestação

Recomenda-se tratamento imediato da gestante, com benzilpenicilina benzatina, após apenas um teste reagente para sífilis (teste treponêmico ou teste não treponêmico).

O tratamento adequado para Sífilis durante a gestação é feito com benzilpenicilina benzatina, conforme o respectivo estágio clínico da Sífilis (Quadro 18) e iniciado até 30 dias antes do parto.

Gestantes que não atendam a esses critérios serão consideradas inadequadamente tratadas. O intervalo ideal entre as doses é de 7 (sete) dias. Caso a gestante não retorne à Unidade de Saúde para receber as doses subsequentes, é necessário realizar imediatamente a busca ativa. Se houver intervalo superior a 9 (nove) dias entre as doses, é necessário repetir o esquema terapêutico completo.

Quadro 18. Tratamento e monitoramento de Sífilis em Gestante

ESTADIAMENTO	ESQUEMA TERAPÊUTICO	MONITORAMENTO
Sífilis recente • Primária; • Secundária; e • Latente recente (até um ano de evolução)	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões de UI, IM dose única, (1,2 milhão de UI em cada glúteo).	VDRL mensal
Sífilis tardia • Sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução); ou • Latente com duração ignorada; e • Sífilis terciária.	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões de UI, IM, 1 vez por semana, (1,2 milhão de UI em cada glúteo) por 3 semanas. Dose total 7,2 milhões de UI.	VDRL mensal
Neurossífilis	Benzilpenicilina potássica/cristalina 18/24 milhões UI ao dia, EV, administradas em dose de 3-4 milhões de UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias.	Exame de LCR de 6/6 meses até a normalização.
Importante: Qualquer intervalo superior a 9 (nove) dias ou inferior a 7 (sete) dias entre as doses, será considerado tratamento inadequado; A cesta de exames padrão para gestantes no SIG SaudeTech não contempla o exame de VDRL, que deverá ser solicitado separadamente, seguindo as orientações do <u>Quadro 09</u> deste protocolo.		

Fonte: Nota Técnica Conjunta nº 01/2025 - SES.DAS/DPS/DTE - Atualização da recomendação do tratamento de Sífilis em Gestantes.



5.4.2. Dessensibilização à Benzilpenicilina Benzatina em Gestante com Sífilis

Usuárias gestantes com suspeita ou alergia comprovada a Benzilpenicilina Benzatina, após realização de investigação médica, serão encaminhadas ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt para realização da dessensibilização conforme **POP nº 28 - Fluxo de encaminhamento de gestante com histórico de alergia à Benzilpenicilina Benzatina para dessensibilização no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS)** (Processo SEI nº 23.0.229066-0).

5.5. Cuidado Periodontal na Gestação

O Ministério da Saúde do Brasil orienta que o dentista realize um pré-natal odontológico, com ao menos 1 (uma) avaliação odontológica, como parte integral do acompanhamento da gestante, visando a saúde da mãe e do bebê.

A atuação do dentista nesse período é fundamental para prevenir e tratar problemas bucais, que podem ter impactos na saúde geral da gestação, como **complicações na gestação** (como parto prematuro e baixo peso do bebê), a **transmissão de bactérias** causadoras de cárie para a criança e o **agravamento de problemas bucais** decorrentes das alterações hormonais.

Após a abertura do pré natal no sistema SIG SaudeTech, em unidades com cirurgião dentista, se houver agenda disponível, encaminhar imediatamente para o atendimento e avaliação do profissional. Se não houver disponibilidade de vaga ou, no caso de UBSF sem cirurgião dentista na equipe, realizar agendamento com o profissional de referência, via sistema SIG SaudeTech.

5.6. Tromboembolismo

O Tromboembolismo Venoso (TEV) refere-se à formação de coágulos sanguíneos nas veias e é considerado uma importante causa de morte materna evitável. O aumento do risco de TEV na gestação e pós-parto ocorre devido a três fatores principais: o sangue da gestante coagula mais facilmente para evitar hemorragias no parto (hipercoagulabilidade); o útero grande comprime as veias, tornando o fluxo sanguíneo nas pernas mais lento (estase venosa); e o processo do parto pode lesionar as paredes dos vasos sanguíneos (lesão endotelial). Esses fatores, combinados, criam o ambiente ideal para a formação de coágulos nas veias.



5.6.1. Prevenção do tromboembolismo

Baseia-se na avaliação de risco individual durante o pré-natal e adoção de medidas gerais como:

- Estímulo à deambulação (caminhada) e mobilização precoce pós-parto;
- Hidratação adequada e evitar longos períodos de imobilidade;
- Controle do peso e cessação do tabagismo;
- Atividade Física;
- Meias de Compressão;
- Parto Normal Preferível.

5.6.2. Prevenção e Tratamento Medicamentoso para tromboembolismo

O principal objetivo do uso da heparina de baixo peso molecular (HBPM) é a anticoagulação do sangue para prevenir e tratar a formação de coágulos (trombos) nas veias.

A Heparina de Baixo Peso Molecular disponível para solicitação é a **Enoxaparina Sódica**, que faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do MS, e o recebimento do medicamento se dá mediante o cumprimento de exigências do protocolo específico encontrados no link [Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia](#).

O medicamento está centralizado na Farmácia Escola que possui orientações gerais disponíveis no link [Obter medicamento na Farmácia Escola](#).

5.7. Gestantes com Agravos à Saúde Possivelmente Relacionadas ao Trabalho

Gestantes com queixas possivelmente relacionadas ao trabalho, devem procurar atendimento na UBSF de referência para iniciar uma investigação detalhada. Após atendimento e manutenção da suspeita da relação do agravo com o trabalho, o médico deverá:

- Iniciar tratamento (se necessário);
- Solicitar afastamento (se necessário);
- Sugerir adequações ao empregador.

Na ocorrência de dúvidas por parte do profissional com relação ao atendimento, ele poderá consultar o [Caderno de Atenção Básica 41 - Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora](#) e poderá entrar em contato com o CEREST (Centro de Referência de Saúde do Trabalhador) via aplicativo de mensagem (47 988147760) para suporte técnico



e discussão do caso e orientações.

Se persistir a dificuldade no manejo, a usuária deverá ser agendada pelo médico para atendimento no CEREST, conforme orientações disponibilizadas no Processo SEI nº 24.0.159559-1, visto que o CEREST não atende à demanda espontânea.

6. CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL DA GESTANTE E PUÉRPERA EM SAÚDE MENTAL

A gestação, o parto e o puerpério são períodos de profundas transformações fisiológicas, hormonais e emocionais na vida da mulher. A saúde mental materna é um componente fundamental da saúde geral e tem impacto direto no bem-estar da mãe, do bebê e da família. A atenção pré-natal e puerperal deve, portanto, ir além do cuidado físico, integrando a avaliação e o acompanhamento da saúde mental de forma contínua e humanizada.

Mulheres com histórico de transtornos psiquiátricos representam uma população de maior risco para o desenvolvimento ou recorrência de doenças mentais durante a gravidez e o puerpério. A gestação, com suas intensas mudanças hormonais e psicológicas, pode ser um fator desencadeante para a descompensação de quadros psiquiátricos preexistentes.

Toda gestação com algum transtorno psiquiátrico importante deve ser considerada de alto risco e a gestante e o feto devem ser monitorados cuidadosamente durante toda a gestação e o pós-parto atuais e seguintes, podendo ser referenciadas ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS (Processo SEI nº 20.0.022906-3).

Atenção: Possíveis dúvidas relacionadas aos cuidados em saúde mental poderão ser dirimidas com o auxílio da teleconsultoria em psiquiatria (Item 4 deste protocolo) ou matriciamento em saúde mental, antes do encaminhamento à Central de Regulação de Joinville.

Orientações relacionadas ao manejo em saúde mental de gestantes estão descritas na **Linha de Cuidado da Saúde Mental** (Processo SEI nº 20.0.137514-4).

6.1. Riscos Psicossociais em Gestante e Puérpera

A identificação de riscos psicossociais é essencial para qualificar o atendimento a gestantes e puérperas, garantindo um cuidado integral e humanizado. Os profissionais devem atuar com escuta qualificada e atenção para presença de riscos psicossociais, como os descritos no Quadro 19.

Quadro 19. Riscos Psicossociais em Gestantes e Puérperas

PRÉ-NATAL	PUERPÉRIO
• Histórico psiquiátrico: Depressão, ansiedade, psicose prévia. • Violência: Doméstica, sexual, psicológica. • Uso de álcool/drogas: Pela gestante ou parceiro. • Falta de apoio social: Isolamento, problemas familiares. • Gestação não planejada: Sentimentos de rejeição ou ambivalência. • Eventos estressantes: Perdas recentes, desemprego. • Sintomas emocionais: Tristeza, ansiedade ou irritabilidade constantes.	• Baby blues prolongado: Tristeza e irritabilidade por mais de 2 semanas. • Histórico de transtorno grave: Alto risco de psicose puerperal. • Parto traumático: Aumenta o risco de TEPT e depressão. • Dificuldade no vínculo: Problemas com a formação do apego com o bebê. • Preocupação excessiva: Medo irracional com a saúde do bebê. • Ausência ou fragilidade de rede de apoio: Orientar sobre a importância do suporte familiar e social na recuperação e bem-estar.

Elaborado: NGQ, 2025

6.2. Encaminhamentos das Gestantes e Puérperas para Serviços de Saúde Mental

O fluxo de encaminhamento das gestantes para cuidados de saúde mental em Joinville é separado por faixa etária e pela complexidade de cada caso.

6.2.1. Situações para Avaliação e Manejo na Atenção Primária (APS)

Os casos de transtornos mentais leves a moderados, que podem ser manejados ambulatorialmente, tanto no manejo medicamentoso como acompanhamento psicológico, devem ser acompanhados na Unidade Básica de Saúde, pela equipe multiprofissional da APS.

6.2.2. Situações para Avaliação e Manejo em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

Os casos de quadro agudo devem ser encaminhados para o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito/impresso em mãos, relatando detalhadamente o atendimento e o motivo do encaminhamento, para atendimento e acompanhamento especializado, com atenção às características de cada serviço:

- CAPS IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil) - até 17 anos, 11 meses e 29 dias;
- CAPS II ou III (Centro de Atenção Psicossocial II e III) - Acima de 18 anos, conforme a região de residência; e
- CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) - Casos de dependência química.



6.2.3. Situações para Avaliação e Manejo em Emergências Hospitalares e Pronto Atendimento

Nos casos mais graves de gestantes e/ou puérperas em situação de emergência em Saúde Mental que estiverem em atendimento na **APS ou CAPS**, o SAMU deverá ser acionado e o mesmo fará a condução dos encaminhamentos que se fizerem necessários. Quando estas usuárias estiverem em atendimento nas **UPAs/PAs**, elas deverão ser estabilizadas e, na necessidade de internação, o serviço deverá seguir as orientações do Item 6.2.4 - Situações que necessitam de internação em leitos de Saúde Mental.

6.2.4. Situações que Necessitam de Internação em Leitos de Saúde Mental

Com a finalidade de garantir a padronização das informações sobre o acesso aos leitos em saúde mental, o **Ofício nº 623/2025/SES/GERSA/JOI** (disponível no Processo SEI nº 25.0.233330-4) informa a relação das unidades hospitalares de referência e os respectivos critérios de encaminhamento, conforme orientações da Gerência Regional de Saúde de Joinville.

7. VIOLÊNCIA

Durante a gestação a mulher está mais vulnerável, e as consequências da violência são significativas para a saúde do binômio mãe-filho, tais como baixo peso ao nascer, abortos, parto e nascimento prematuros e até mortes materna e fetal.

Importante: Todas as formas de violências identificadas devem ser notificadas e encaminhadas ao NPVA - Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes, na Vigilância Epidemiológica (VE) através do e-mail npva@joinville.sc.gov.br em até 24 horas após o acolhimento do usuário na unidade de saúde.

7.1. Violência Sexual

Em Joinville, as orientações com relação ao atendimento das violências sexuais estão disponíveis no *link* do [Protocolo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual](#), também disponível no Processo SEI nº 23.0.213387-5, orienta sobre o atendimento às pessoas em situação de violência sexual na Secretaria da Saúde.



7.2. Outras Violências

As orientações com relação ao atendimento de todos os tipos de violência estão disponíveis no site da prefeitura pelo *link* da [Cartilha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher](#).

8. SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS QUE INDICAM AVALIAÇÃO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

Ao ser identificada uma gestante com fatores de risco, conforme Quadro 20, o médico deverá orientar a gestante a se dirigir à maternidade para avaliação, com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito/impresso em mãos, relatando detalhadamente o atendimento e o motivo do encaminhamento.

Se for identificada uma urgência ou emergência, avaliar a necessidade de solicitar transporte via SAMU.

Os profissionais de saúde que atuam no Serviço de Urgência e Emergência Obstétrica da Maternidade Darcy Vargas, deverão avaliar as gestantes encaminhadas e confirmar, ou não, o diagnóstico inicial, assim como, determinar a conduta necessária para cada caso:

- Internação hospitalar;
- Referência ao Ambulatório de PNAR ou
- Contrarreferência para acompanhamento pela equipe da APS, via módulo de contrarreferência no SIG-SaúdeTech, conforme **POP nº 19 - Transferência do Cuidado via Notificação de Contrarreferência** (Processo SEI nº 20.0.144936-9).

Quadro 20. Fatores de Risco Gestacional que indicam avaliação em Serviço de Urgência e Emergência Obstétrica

Fatores de Risco Gestacional que indicam avaliação em Serviço de Urgência e Emergência Obstétrica
Hemorragias na gestação (incluindo descolamento prematuro de placenta e placenta prévia).
Hipotensão arterial (PA<90x60mmHg).
Crise hipertensiva (PA≥160/110mmHg) acima de 20 semanas: todas devem ser encaminhadas (<u>com Cartão da Gestante e encaminhamento escrito/impresso em mãos</u>) para avaliação na emergência obstétrica da MDV, pós sulfatação na Unidade de Saúde ou não.
Sinais premonitórios de eclâmpsia (escotomas cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito com ou sem hipertensão arterial grave e/ou proteinúria).
Eclâmpsia/convulsões.
Condições clínicas de emergência: cefaleia intensa e súbita, sinais neurológicos, crise aguda de asma, edema agudo de pulmão.



Suspeita ou diagnóstico de pielonefrite (dor lombar ou no flanco, febre e sintomas urinários).
Suspeita de infecção ovular ou corioamnionite (temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$ com dor abdominal ou corrimento/líquido vaginal fétido).
Anemia grave ($\text{Hb} < 8,0\text{g/dL}$) ou sintomática (dispneia, taquicardia, hipotensão).
Sinais de insuficiência respiratória aguda (dispnéia ou falta de ar, cianose, $\text{SatO}_2 \leq 90\%$ ou $\text{FR} \geq 30\text{ipm}$).
Suspeita de trombose venosa profunda (dor intensa em membro inferior associado a vermelhidão e edema localizados).
Ruptura prematura de membranas (perda súbita/jorro de líquido vaginal claro ou transparente sem contrações e com < 37 semanas).
Sinais e sintomas sugestivos de abortamento em curso ou inevitável (sangramento vaginal ativo associado a dor abdominal, presença de colo aberto, saída de material sugestivo de restos ovulares ao exame especular).
Trabalho de parto prematuro (contrações e modificação de colo uterino em gestantes com menos de 37 semanas).
Gravidez ectópica.
Descolamento prematuro da placenta (DPP).
Dor abdominal intensa / suspeita de abdome agudo.
Gestação a partir de 41 semanas.
Hipertermia (temperatura axilar $\geq 38^{\circ}\text{C}$), na ausência de sinais ou sintomas de infecção das vias aéreas superiores.
Prurido gestacional/ictêria.
Hiperêmese gravídica com sinais de alerta tais como perda de peso significativa (geralmente mais de 5% do peso pré-gravidez), incapacidade de reter qualquer líquido por mais de 12 horas, sinais de desidratação, como tontura ou pouca urina, presença de sangue no vômito, vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento oral ou com desidratação.
Vômitos inexplicáveis a partir de 20 semanas de gestação.
Restrição de crescimento intrauterino (CIUR).
Oligodrâmnio (volume baixo de líquido amniótico).
Polidrâmnio grave ou sintomático (volume excessivo de líquido amniótico).
Movimentos fetais diminuídos/ausentes.
Óbito fetal.
Mulheres em situações de violência.
Incompetência Istmo-cervical com IG próxima à necessidade de realizar o procedimento da cerclagem (13-16 semanas) sem encaminhamento prévio.
Colo curto ($\leq 25\text{mm}$) + histórico de prematuridade com indicação de cerclagem (até 24 semanas, após não é realizada mais cerclagem).

Elaborado: NGQ, 2025



9. PARTO

O Sistema Único de Saúde (SUS) adota a política de atenção humanizada ao parto e nascimento, com foco no protagonismo da mulher, na segurança da mãe e do bebê, e no respeito às evidências científicas e às escolhas informadas da gestante.

Os princípios deste atendimento se baseiam em:

- **Vínculo e acompanhamento:** A equipe da Atenção Básica (UBS) e a equipe da maternidade de referência trabalham de forma integrada para garantir a continuidade do cuidado.
- **Parto humanizado:** Prioriza-se o parto normal, com o mínimo de intervenções desnecessárias. São incentivados métodos não farmacológicos para alívio da dor (massagem, banho morno, bola suíça).
- **Direito a acompanhante:** A gestante tem direito a ter uma pessoa de sua escolha, como acompanhante, durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- **Informação e consentimento:** Todas as intervenções devem ser explicadas à gestante e à sua família, e o consentimento deve ser obtido. A gestante tem o direito de recusar procedimentos não essenciais.
- **Alojamento conjunto e amamentação:** Mãe e bebê permanecem juntos no pós-parto, com incentivo à amamentação na primeira hora de vida.

9.1. O Parto e a Violência Obstétrica

A violência obstétrica é definida em lei (Lei Nº 18.322/22) como todo ato praticado pelo médico, equipe de saúde do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda no período do puerpério.

O Processo SEI nº 22.0.114436-7 trata do tema e disponibiliza cartaz informativo, que deverá ser disponibilizado em todas as Unidades que prestam assistência em saúde.

9.2. Doação Voluntária e Família Acolhedora

O Processo SEI nº 17.0.048020-8 contém Fluxos Intersetoriais de Atendimento e Encaminhamento nas Áreas da Saúde e da Assistência Social no Âmbito do Município de Joinville, destacando rotinas e encaminhamentos relacionados à **Família Acolhedora**.

A *Lei 13.509 de 22/11/2017*, dispõe sobre **Entrega Voluntária do recém nascido, destituição do poder familiar, acolhimento, apadrinhamento, guarda e adoção de crianças**

e adolescentes e a Cartilha do Conselho Nacional de Justiça: [Entrega Voluntária Para Adoção - Orientações para Gestantes e Familiares](#) orienta sobre a temática de maneira clara e didática para os envolvidos.

Importante: Quando for informado o desejo da **Doação Voluntária** (no pré-natal ou após o nascimento) e/ou o acionamento da **Família Acolhedora**, o Serviço de Assistência Social da MDV, deve encaminhar todas as informações via contrarreferência, conforme Nota Orientativa Conjunta sobre contrarreferências entre a Maternidade Darcy Vargas e a Atenção Primária à Saúde (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

A UBSF a qual a gestante e/ou puérpera com **doação voluntária** está vinculada deve garantir atendimento com sigilo quando for procurada por demanda espontânea, mas não deverá realizar nenhuma busca ativa.

A **família acolhedora** ou **instituição acolhedora** (responsável legal), será orientada a procurar a UBSF mais próxima do seu endereço para o atendimento da criança. Neste atendimento deve-se atualizar o cadastro da criança se atentando para as seguintes informações:

- **Nome da criança:** informar o nome conforme certidão de nascimento e, na ausência desta, seguir as orientações que constam na declaração da Família Acolhedora;
- **Nome da Mãe:** escrever “Família Acolhedora”;
- **Endereço:** informar o endereço fornecido pelo responsável legal.

Em caso de dúvidas se a criança está sob a responsabilidade da **família acolhedora** ou **instituição acolhedora**, entrar em contato com a Serviço de Acolhimento Familiar através do e-mail: familiasacolhedoras@joinville.sc.gov.br ou por meio do telefone: (47) 98840-4202.

10. CONSULTA DE PUERPÉRIO E DO RECÉM NASCIDO

A consulta de puerpério na atenção primária é uma etapa crucial para garantir a continuidade do cuidado integral à mulher (com o fechamento de pré-natal no prontuário eletrônico) e ao recém-nascido (com a realização do Teste do Pezinho em tempo oportuno).

O POP nº 41 orienta sobre a rotina para a **Primeira Avaliação do Recém-Nascido (RN) e Puérpera até o quinto (5º) dia de vida da Criança (Primeira Semana de Saúde Integral)** (Processo SEI nº 21.0.211798-1).

A Maternidade Darcy Vargas deve fazer a contrarreferência para a APS de todas as altas das Gestantes, Puérperas e RNs, de acordo com a **Nota Orientativa**

Conjunta nº 21/2025 - Orientações da Contrarreferência da Maternidade Darcy Vargas (MDV) para a Atenção Primária à Saúde (APS) para o agendamento de consultas de Gestante, Puérpera e RN residentes em Joinville (Processo SEI nº 25.0.239921-6).

Importante: No momento da primeira consulta puerperal, é obrigatório a finalização do Pré-natal no sistema SIG SaudeTech.

Na primeira consulta, além de observar as orientações feitas na contrarreferência da MDV, a equipe da APS deve se atentar aos cuidados essenciais do período como:

- **Avaliar:**

- **Saúde da puérpera:** verificar sinais vitais, involução uterina, sangramento, cicatrização (se parto cesárea ou episiotomia) e queixas gerais;
- **Saúde do recém-nascido:** examinar o bebê, checar vacinas (BCG e Hepatite B), triagem neonatal (teste do pezinho, linguinha, orelhinha, olhinho e coraçãozinho) e acompanhar o ganho de peso;
- **Estado emocional:** usar escuta qualificada para identificar sintomas de tristeza, ansiedade ou depressão pós-parto, com atenção especial a indicadores de risco psicossocial.

- **Orientar:**

- **Amamentação:** apoiar e monitorar a pega e o manejo, esclarecendo dúvidas;
- **Contracepção:** discutir métodos contraceptivos, considerando a individualidade da mulher e o aleitamento materno;
- **Cuidados com o bebê:** instruir sobre higiene, sono, prevenção de acidentes e sinais de alerta.

- **Acolher:**

- **Família:** incluir o parceiro ou outros familiares na consulta para fortalecer a rede de apoio.

Importante: É fundamental, na primeira consulta do puerpério, conforme [link](#) [NOTA INFORMATIVA CONJUNTA Nº 012/2021 - DAPS/DIVE/SPS/SUV/SES/SC - Orientações sobre a amamentação e a infecção pelo HIV:](#)

- Aconselhar sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis nas consultas puerperais e de rotina da Unidade Básica de Saúde (UBS) por meio do uso de preservativo, especialmente, durante o período de lactação;



- Realizar testagem para HIV em mulheres lactantes, ao menos no 3º mês e no 9º mês após o parto, se estas se mantiverem amamentando. Nestas ocasiões, oferecer testagem também para o parceiro;
- Realizar a testagem mencionada acima, preferencialmente, por teste rápido (TR) no momento da consulta de puericultura de rotina na UBS na qual a mulher está vinculada.
- O município de Joinville orienta que, além da testagem para HIV, também devem ser ofertados à puérpera os testes de sífilis, HTLV e hepatites B e C.

10.1. COMPLICAÇÕES PUERPORAIS QUE NECESSITAM SER NOTIFICADAS PARA A MATERNIDADE

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da Maternidade Darcy Vargas **orienta que na diagnósticos das condições pós-parto listadas abaixo, seja realizada** uma notificação pelo enfermeiro ou médico da UBSF via e-mail para o endereço eletrônico: ccih_mdv@saude.sc.gov.br.

O manejo na atenção básica é limitado e o encaminhamento ágil é vital para evitar complicações graves, como sepse.

Importante: Em caso de suspeita de qualquer uma das complicações citadas abaixo, a puérpera deve ser imediatamente orientada a procurar a maternidade, com encaminhamento escrito/impresso em mãos, para confirmação diagnóstica e tratamentos realizados.

Todos os atendimentos devem ser evoluídos em prontuário eletrônico.

10.1.1. Endometrite

A endometrite puerperal é a infecção bacteriana do endométrio (camada interna do útero) e que geralmente ocorre no período pós-parto. A causa mais comum é a contaminação polimicrobiana por bactérias que ascendem do trato genital inferior. Os sinais e sintomas incluem febre persistente, dor abdominal ou pélvica, sensibilidade e amolecimento uterino, mal-estar e secreção vaginal, que pode ter odor fétido e ser purulenta. O diagnóstico é predominantemente clínico, baseado na avaliação dos sintomas e sinais.

Orientar a usuária a procurar a maternidade, com encaminhamento escrito/impresso em mãos, para confirmação diagnóstica e tratamentos realizados.

10.1.2. Infecção de Sítio Cirúrgico - ISC

A equipe da ESF deve estar atenta à ISC pós-parto, especialmente após cesarianas. Os sinais de alerta que indicam infecção incluem: drenagem purulenta, dor



intensa, inchaço, vermelhidão, febre, e abertura da ferida (deiscência).

Em caso de ISC superficial sem febre ou outros sinais sistêmicos, a usuária pode ser orientada a fazer curativos na própria UBSF e em domicílio. Contudo, se houver febre, suspeita de infecção profunda ou deiscência, a puérpera deve ser encaminhada imediatamente para a maternidade de referência, com encaminhamento escrito/impresso em mãos, para confirmação diagnóstica e tratamentos realizados.

10.1.3. Infecção de Episiotomia

A equipe da UBSF deve inspecionar a ferida da episiotomia em puérperas com parto vaginal, especialmente nas visitas domiciliares, para identificar sinais de infecção. Fique atento à vermelhidão, inchaço, calor, dor intensa, deiscência (abertura dos pontos) e secreção purulenta ou com mau odor. Embora a orientação sobre higiene local seja fundamental, qualquer suspeita de infecção, especialmente se acompanhada de febre ou comprometimento do estado geral, deve levar ao encaminhamento escrito/impresso imediato da puérpera para a maternidade para avaliação e tratamento adequados, evitando complicações graves.

11. PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO

Na ocorrência de dificuldades relacionadas ao manejo da amamentação, a equipe da UBSF poderá acionar a Unidade de Saúde Digital (USD) - Ligue Web Saúde, conforme rotina interna.

Se necessário o encaminhamento ao Banco de Leite, o mesmo deverá ser entregue à usuária de maneira impressa ou digital.

A avaliação no Banco de Leite pode ser realizada das seguintes maneiras:

- **Demanda Espontânea ou Agendamento:**

- Por meio do telefone 3481-0151 (pela equipe da UBSF, usuária ou familiar); **ou**
- Acesso direto ao serviço via recepção central da MDV ou Emergência Obstétrica.

- **RN sem ganho de peso pela baixa produção láctea:**

- Agendamento por meio do telefone 3481-0151 (pela equipe da UBSF, usuária ou familiar).

- **Situações graves que permaneça a dificuldade no manejo:**

- Situações como mastite, abscessos mamários, lesões de mama, fissura, obstrução de ducto, ingurgitamento mamário severo:

- Acesso direto ao serviço via recepção central da MDV ou Emergência Obstétrica.

Importante: Todos os atendimentos, procedimentos e prescrições realizadas pelo Banco de Leite, deverão ser descritas em Contrarreferência para as UBSF, orientando o manejo sequente.

O Banco de Leite da MDV realiza atendimento 24h por dia e todos os dias da semana.

12. INDICADORES

12.1. Indicadores Gerais Rede Alyne

Os indicadores da Rede Alyne, que norteiam este Protocolo de Pré-natal, estão diretamente relacionados às metas do programa, que visam aprimorar a saúde materna e infantil no país, com o **objetivo principal de reduzir a mortalidade materna e neonatal no Brasil, com foco especial em equidade racial e regional**.

As orientações estão descritas na Portaria GM/MS Nº 5.349 de 12/09/2024 (que dispõe sobre o financiamento da Rede Alyne) e definem indicadores específicos da Rede Alyne, conforme descrito abaixo.

12.2. Indicadores Específicos da Rede Alyne

O link da [Nota Metodológica C3 - Cuidado na Gestação e Puerpério](#) descreve os indicadores da Rede Alyne para qualificar o acompanhamento de gestantes e puérperas na APS.

Estes indicadores do MS estabelecem que o recebimento do cofinanciamento federal está diretamente vinculado ao alcance destes indicadores de saúde materna e infantil pactuados, incentivando a melhoria da qualidade da assistência

É fundamental que os profissionais conheçam os indicadores atualizados, planejem estratégias para o alcance dos mesmos e o monitoramento contínuo de seus resultados.

Estes indicadores específicos estão descritos no Item 12.2.1, mas poderão sofrer alterações conforme ocorram atualizações na legislação e o gestor precisa estar atento a fontes de informações e aos serviços da SMS que auxiliem neste processo de compartilhamento de informações relacionadas aos indicadores, como a área de Planejamento Estratégico.

O SEI 25.0.284397-3 apresenta o **Guia Prático de Bolso**, com o objetivo de facilitar o acesso às informações relacionadas aos indicadores e orientar quanto aos códigos de registro disponíveis e/ou obrigatórios.



12.2.1. Indicador C3 - Cuidado na Gestação e Puerpério

- **Acompanhamento da gestante:**

- Registro da realização da primeira consulta de pré-natal até a 12ª semana de gestação;
- Registro de, ao menos, 7 (sete) consultas de pré-natal durante a gestação;
- Registro de, ao menos, 7 (sete) aferições de pressão arterial ao longo da gestação;
- Registro de, ao menos, 7 (sete) medições de peso e altura na gestação;
- Registro de, ao menos, 3 (três) visitas domiciliares realizadas pelo ACS após a primeira consulta de pré-natal;
- Registro da administração da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (dTpa) a partir da 20ª semana;
- Registro da realização de testes rápidos ou exames para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C no primeiro trimestre;
- Registro da realização de testes rápidos para sífilis e HIV no terceiro trimestre;
- Registro de, ao menos, 1 (uma) consulta com cirurgião dentista durante a gestação.

- **Acompanhamento da puérpera:**

- Registro da realização de, ao menos, 1 (uma) visita domiciliar do ACS no puerpério;
- Registro de, ao menos, 01 (uma) consulta presencial ou remota realizada por médico ou enfermeiro durante o puerpério, sendo que, no município de Joinville é definido que a primeira avaliação do Recém-Nascido (RN) e Puérpera seja realizada até o quinto (5º) dia de vida da Criança, conforme POP 41, disponível no SEI 21.0.211798.

13. ALTERAÇÕES DO PROTOCOLO DE PRÉ-NATAL (VERSÃO 2020 PARA 2025)

A versão 2025 do Protocolo de Pré-Natal de Joinville constitui uma atualização substancial, destinada a orientar e padronizar a assistência na Atenção Primária à Saúde (APS), focada em alinhar as práticas locais às novas diretrizes federais, refinar a avaliação de risco e introduzir rotinas de profilaxia obrigatórias.

A tabela a seguir apresenta uma comparação concisa e estruturada entre as versões do Protocolo de Pré-natal, destacando as principais alterações e atualizações



introduzidas.

Quadro 21. Alterações das versões do Protocolo de Pré-natal 2019 para 2025

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2019	VERSÃO 2025
Estrutura de Classificação de Risco Gestacional	Utiliza o Formulário de Classificação de Risco Gestacional com apenas dois níveis: Risco Habitual e Alto Risco. -Não havia menção ao Médio Risco.	Utiliza o Instrumento de Classificação de Risco Gestacional do Estado de Santa Catarina. Classificação em três níveis: Baixo Risco (Até 4 pontos), Médio Risco (5 a 9 pontos) , e Alto Risco (10 ou mais pontos).
Condução da Gestante de Risco Intermediário	Não existia uma categoria de risco intermediário (Médio Risco) formalmente definida para o manejo.	Publicação pela Secretaria de Estadual de Saúde do novo instrumento de estratificação de risco gestacional com inclusão do Médio Risco (Risco Intermediário) que deve ser acompanhado pela equipe da APS e ter avaliação do especialista (ginecologista obstetra - GO), quando necessário.
Avaliação Pré-Concepcional	As orientações de saúde pré-gestacional eram mencionadas no contexto de planejamento familiar e na suplementação de ácido fólico.	Inclui uma seção dedicada (Seção 1) à Avaliação Pré-Concepcional, detalhando a avaliação de hábitos, estilo de vida e manejo de doenças crônicas antes da concepção. Inclui avaliação da parceria.
Suplementação de Ácido Fólico	Suplementação de 5mg/dia recomendada sem detalhamento.	Suplementação universal de 5mg/dia recomendada idealmente 3 meses antes da concepção até a 12ª semana completa (12 semanas e 6 dias) de gestação.
Teleconsultoria	Não havia menção a estratégia de teleconsultoria para outras especialidades além da teleconsultoria no pré-natal	Sugere a utilização da teleconsultoria em várias especialidades quanto ao surgimento de dúvidas no manejo da gestante, via plataforma do Telessaúde.
Profilaxia de Síndromes Hipertensivas (Cálcio)	Não havia menção à suplementação universal de Carbonato de Cálcio como profilaxia.	Suplementação universal de Carbonato de Cálcio (500 mg, 1 comp. 12/12h) para todas as gestantes a partir da 12ª semana até o parto, com início máximo em 20 semanas.
Profilaxia de Síndromes Hipertensivas (AAS)	Não havia menção à profilaxia específica com AAS.	Indicação de profilaxia com AAS 100 mg/dia para gestantes com 1 fator de risco alto ou 2 ou mais fatores de risco moderados, com interrupção às 36 semanas.
Prevenção e tratamento do Tromboembolismo	Não havia menção ao manejo do Tromboembolismo	Prevenção e tratamento do tromboembolismo e a indicação da medicação (Enoxaparina) disponível na Farmácia Escola com critérios definidos pelo MS.
Exames Incluídos na Rotina do 1º Trimestre	Incluía Testes Rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), Hemograma, Glicemia Jejum, Toxoplasmose e	Mantém os exames anteriores, mas adiciona rastreamento para TSH (em gestantes com fatores de risco), PCR para

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2019	VERSÃO 2025
	Eletroforese de Hemoglobina	clamídia e gonococo (em gestantes ≤ 30 anos ou com fatores de risco) e sorologia para HTLV.
Tratamento de Sífilis (Intervalo de Doses)	Qualquer intervalo superior a 14 dias entre as doses de benzilpenicilina benzatina era considerado tratamento inadequado.	Qualquer intervalo superior a 9 (nove) dias entre as doses de benzilpenicilina benzatina será considerado tratamento inadequado e exige reiniciar o esquema terapêutico completo.
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e Teleconsultoria	DMG ou DM pré-gestacional exigia Teleconsultoria para Gestação de Alto Risco para o PNAR.	O diagnóstico de DMG ou DM pré-gestacional pode ser feito teleconsultoria em endocrinologia, com o encaminhamento ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco (PNAR) sendo restrito a apenas alguns casos específicos (ex: necessidade de insulinoterapia), conforme Instrumento de Estratificação de Risco.
Urgências Hipertensivas (Sulfatação na APS)	Crise hipertensiva (PA > 160/110 mmHg) indicava encaminhamento à Emergência Obstétrica da MDV.	Se PA $\geq 160 \times 110$ mmHg, ou se PA $\geq 140 \times 90$ mmHg COM sinais de alarme (iminência de eclâmpsia), a equipe da APS pode iniciar a Dose de Ataque do Sulfato de Magnésio (MgSO ₄ 10%) antes do encaminhamento à MDV.
Acompanhamento Puerperal (Consultas)	Garantir 1 (uma) consulta no puerpério (até 42 dias).	Garantir duas consultas: a primeira, preferencialmente conjunta com o RN, entre o 3º até o 5º dia do pós-parto; e a segunda, entre o 30º e 40º dias pós-parto.
Indicadores de Desempenho	O Protocolo baseia-se nas diretrizes da Rede Cegonha, mas não explicitava indicadores numéricos federais atrelados a financiamento.	Os indicadores da Rede Alyne (C3) são listados e atrelam o cofinanciamento federal ao cumprimento de metas quantitativas, como: 7 consultas, 7 aferições de PA, 3 visitas domiciliares do ACS, e TR/Exames para ISTs no 1º e 3º trimestres, etc.
Violência (Notificação)	As formas de violência identificadas devem ser notificadas e encaminhadas ao NPVA.	Exige que todas as formas de violência identificadas sejam notificadas e encaminhadas ao NPVA através do e-mail npva@joinville.sc.gov.br em até 24 horas após o acolhimento.
Saúde Mental	Gestação com transtorno psiquiátrico importante deve ser considerada de alto risco, com fluxo de encaminhamento para HJAF (até 14 anos) ou HRHDS (a partir de 15 anos).	Mantém gestação com transtorno psiquiátrico importante como alto risco e detalha a lista de Riscos Psicossociais. Enfatiza o uso da teleconsultoria em psiquiatria como auxílio antes do encaminhamento.
Pré-Natal do Parceiro	Incentivava a participação do pai/parceiro nas consultas e a realização de exames.	Exige o registro do Procedimento "Consulta Pré-Natal do Parceiro" (código SIGTAP: 03.01.01.023-4). Também requer a entrega da Cartilha Mãe Joinvilense.

Elaborado: NGQ, 2025

Consulta Técnica



REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Cartilha "Entrega Voluntária para Adoção": orientações para gestantes e familiares.** Brasília, DF: CNJ, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 386 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Atenção ao pré-natal de baixo risco.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. 318 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 32).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. **Manual de Gestão de Alto Risco.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. 230 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 3.493, de 27 de maio de 2024. **Institui Nova Metodologia de Cofinanciamento Federal do Piso de Atenção Primária à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. **Gestação em Mulheres com Doença Falciforme.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_mulheres_doenca_falciforme.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Saúde do trabalhador e da trabalhadora** [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. 140 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 41).

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 5.350, de 12 de setembro de 2024. **Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede Alyné.** Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 5.349, de 12 de setembro de 2024. **Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento da Rede Alyné.** Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellito Tipo 1.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. 68 p. (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 17, de 12 de novembro de 2019). Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_terapeuticas_diabete_mellito.pdf. Acesso em: 6 nov. 2025.



BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais.** 2. ed. rev. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 224 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_hiv_sifilis_hepatites.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: versão resumida.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. 64 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_norm_al-versao-resumida.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).** Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 183, Seção 1, p. 68, 22 set. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres.** Elaboração: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. 230 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. **Guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. 58 p. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/publicacoes/guia-pre-natal-do-parceiro-para-profissionais-de-saude>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 250 p. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/view.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira.** 2. ed., 1. reimpr. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. 156 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. **Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes: Programas Vitamina A e de Ferro.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 51 p. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/cgan/programa-nacional-de-suplementacao-d-e-micronutrientes/Caderno_PNSM_2022.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. **Manual de gestão de alto risco.** 6. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 592 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf. Acesso em: 6 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005. **Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 abr. 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. 163 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prenatal_puerperio_atencao_qualificada_humanizada_manual_tecnico.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. **Nota Técnica Conjunta nº 251/2024-COEMM/CGESMU/DGCI/SAPS/MS e CGAN/DEPPROS/SAPS/MS. Recomendações para a suplementação universal de cálcio durante a gestação.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-conjunta-no-251-2024-coemm-cgesmu-dgci-saps-ms-e-cgan-deppros-saps-ms.pdf>.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Recomendação CFM nº 2/2013. Ementa: **Recomenda-se a administração de ácido fólico em mulheres em idade fértil e que planejam engravidar, além daquelas com fatores de risco, no intuito de prevenir defeitos abertos do tubo neural.** Brasília, DF, 2013. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/recomendacoes/BR/2013/2>.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (COREN/SC). Parecer COREN/SC nº 002/CT/2013. Ementa: **Solicitação de parecer técnico acerca de prescrição/administração de medicamentos e exames laboratoriais por Enfermeiro.** Florianópolis, SC, 2013. Disponível em: <http://www.corensc.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/02/Parecer-002-2013-CT-Prescricao-e-exames-laboratoriais.pdf>.

FIGUEIREDO ALVES, R. R.; NONATO, D. R.; CUNHA, A. M. HTLV e gravidez: protocolo clínico. Femina, São Paulo, v. 47, n. 2, p. 110-113, fev. 2019. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/12/1046499/femina-2019-472-110-113.pdf>.

JOINVILLE (SC). Secretaria Municipal de Saúde. **Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Pessoa com Sífilis.** Joinville, SC: SMS, 2023.

JOINVILLE (SC). Secretaria Municipal de Saúde. **Nota Técnica Conjunta nº 01/2025-SES.DAS/DPS/DTE.** Ementa: **Atualização da recomendação do tratamento de Sífilis em Gestantes.** Joinville, SC: SMS, 2025.



JOINVILLE (SC). Secretaria Municipal de Saúde. Gerência de Enfermagem e Núcleo de Gestão Assistencial. **Protocolo de Enfermagem COREN/SC: Volume 3 - Saúde da Mulher.** SEI 23.0.235281-0. Joinville, SC: SMS.

KORKES HA, Ramos JGL, de Oliveira LG, Sass N, Peraçoli JC, Cavalli RC, Martins-Costa SH, de Sousa FLP, Cunha Filho EV, Mesquita MRS, Corrêa Jr MD, Araujo ACPF, Zaoneta ACM, Freire CHE, Rocha Filho EAP, Costa ML. **Pré-eclâmpsia-Protocolo 2025.** Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS) et al. **Tratamento do diabetes mellitus gestacional no Brasil.** Brasília, DF: OPAS, 2019. 104 p. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51761>.

RAMOS JGL, Korkes HA, de Oliveira LG, Sass N, Peraçoli JC, Cavalli RC, Martins-Costa SH, de Sousa FLP, Cunha Filho EV, Mesquita MRS, Corrêa Jr MD, Araujo ACPF, Zaoneta ACM, Freire CHE, Rocha Filho EAP, Costa ML. **Síndrome Hellp - Protocolo 2025.** Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2025.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. Deliberação 057/CIB/2019. **Aprova a Nota Técnica nº 02/2019/GEABS/SUG/SES de Implantação do Teste Mãe Catarinense.** Florianópolis, SC, 2019. Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/index.php/informacoes-e-publicacoes/documentos-e-formularios/cib/deliberacoes-2019/1271-deliberacao-057-cib-2019/file>.

SANTA CATARINA. Lei nº 17.097, de 17 de janeiro de 2017. **Dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Santa Catarina.** Florianópolis, SC, 2017. Disponível em: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2017/17097_2017_lei.html.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE). **Manual técnico de orientações sobre o manejo da toxoplasmose.** Florianópolis, SC: SES/DIVE, 2025. Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Toxoplasmose/Publica%C3%A7%C3%B5es/manual%20de%20orientaes%20-%20toxoplasmose%202025.pdf>.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. Deliberação 158/CIB/2025, de 10 de julho de 2025. **Aprova o instrumento de estratificação do risco gestacional retificado, conforme detalhamento nesta deliberação.** Retificada em 14 de out. de 2025. Florianópolis, SC, 14 out. 2025. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/legislacao/legislacao-geral/deliberacoes/deliberacoes-2025/deliberacao-158-cib-2025-aprova-o-instrumento-de-estratificacao-do-risco-gestacional-conforme-detalhamento-nesta-deliberacao/download>.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Comitê Estadual e Prevenção de Óbitos Materno, Infantil e Fetal (CEPOMIF). **Nota de Recomendação nº 001/2025 - CEPOMIF/SC. Assunto: Atenção à gestante de alto risco no estado de Santa Catarina.** Florianópolis, SC: DIVE/SES, 2025. Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/CEPOMIF/NR01-2025.pdf>.

SANTA CATARINA. Defensoria Pública. Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das

Mulheres (NUDEM). **Violência Obstétrica: Enfrentar para Humanizar**. Florianópolis: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, 2022. Disponível em: https://defensoria.sc.def.br/uploads/cartilhas/anexos/VIOLENCIAOBSTETRICAENFRENTARPARAHUMANIZAR_62ab91e022317.pdf.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Protocolo de Acesso e Classificação de Risco**. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/regulacao/protocolo-de-acesso-e-classificacao-d-e-risco>.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **Manual Técnico de Orientações sobre o Manejo da Toxoplasmose**. Florianópolis, SC: DIVE/SES, 2025. Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Toxoplasmose/Publica%C3%A7%C3%B5es/manual%20de%20orientaes%20-%20toxoplasmose%202025.pdf>.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Nota Técnica Conjunta nº 4/2024 - DAPS/DIVE/LACEN/SPS/SUV/SES/SC. **Assunto: Dispõe sobre a implantação do diagnóstico molecular da Clamídia e Gonococo (CT/NG) na rede de atenção (PCDT/IST)**. Florianópolis, SC: SES/SC, 2024. Disponível em: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/notas-tecnicas/notas-tecnicas-2024/NT04_2024.pdf.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Atenção Integral à Saúde. **Linha de Cuidado Materno Infantil**. Florianópolis, SC: SES/SC, 2019.

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN. Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde com Foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada – Saúde da Mulher na Gestação, Parto e Puerpério. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes – Edição 2025. São Paulo: SBD, 2025. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/>. Acesso em: 3 nov. 2025.

SOUZA, Renato Teixeira. **Infecção urinária** [flowchart]. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2023. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/fluxopdf/assets/pdf/Infeccao-urinaria.pdf>.